CGU
Controladoria-Geral da União

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Ministério da Saúde

Exercício 2023

5 de junho de 2025

Controladoria-Geral da União (CGU)
Secretaria Federal de Controle Interno (SFC)

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
Órgão: **Ministério da Saúde**
Município/UF: Brasília/DF
Relatório de Avaliação: **1452250**

Missão
Promover a integridade e o enfrentamento da corrupção de modo que o governo federal possa entregar políticas e serviços públicos efetivos.

Avaliação
O trabalho de avaliação, como parte da atividade de auditoria interna, consiste na obtenção e na análise de evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou conclusões independentes sobre um objeto de auditoria. Objetiva também avaliar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos relativos ao objeto e à Unidade Auditada, e contribuir para o seu aprimoramento.

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO PELA CGU?

Auditoria de Avaliação realizada no Ministério da Saúde sobre o macroprocesso de Gestão de Insumos Estratégicos em Saúde (IES), contemplando:

1) Análise sobre as perdas efetivas no período de 2021 a 2023;

2) Análise sobre as perdas em potencial no período de 2021 a 2023 e hipóteses de subdimensionamento das perdas;

3) Análise de fatores relacionados às perdas efetivas e em potencial.

Os testes de auditoria abrangeram o período de 2021 a 2023 e compreenderam as etapas de recebimento, armazenamento, gestão de estoques, distribuição e eventual descarte de IES.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE TRABALHO?

Além da materialidade (R$ 62,9 bilhões entre 2021 e 2023) e da relevância social (garante o acesso regular de medicamentos e insumos para atendimento da população em todo o território nacional), a criticidade também foi considerada, devido a inconsistências nos registros contábeis identificados nas auditorias anuais de contas (2021 e 2022), e devido a reportagens sobre incineração de medicamentos e vacinas.

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS AS RECOMENDAÇÕES QUE DEVERÃO SER ADOTADAS?

No período de 2021 a 2023 foram descartados insumos correspondentes a R$ 2.076.391.671,36 em vacinas, em sua maioria adquiridas durante a Pandemia de Covid-19 e, portanto, sujeitos a uma situação atípica e menos previsível, e R$ 24.251.462,78 em insumos relacionados a demandas judiciais. Os demais insumos, que totalizaram R$ 213.071.944,17, são de uso ordinário e passíveis de maior previsibilidade na gestão, tiveram perdas, associadas aos seguintes fatores: 1) inexistência de parâmetros de aceitabilidade de perdas; 2) fragilidades nos sistemas de gestão de estoques e nos controles sobre o montante de perdas; 3) descumprimento de pontos da Portaria GM/MS nº 4.777/2022, que estabelece ações para prevenção de perdas; 4) inadequações em dispositivos dessa mesma portaria, em especial quanto a procedimentos de controle; 5) fatores relacionados a logística; e 6) recebimento de insumos com validade inferior a 70% da vida útil, o que aumenta o risco de perda ao longo da cadeia logística.

Em função desses achados, foram elaboradas recomendações, em conjunto com os gestores do MS, no sentido de definir percentuais aceitáveis de perda para insumos; melhoria de controle de perdas; aperfeiçoamento de normativos relacionados à gestão de IES, dentre outras.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

AAC	Auditoria Anual de Contas
AECI	Assessoria Especial de Controle Interno
BI	*Business Intelligence*
BNAFAR SUS	Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica no
CERF	Central Estadual de Rede de Frio
CGEAF Farmacêutica	Coordenação-Geral do Componente Especializado da Assistência
CGGI	Coordenação-Geral de Gestão de Insumos
CGINTE	Coordenação-Geral de Interlocução com Órgãos de Controle
CGLOG	Coordenação-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para a Saúde
CGPLAM	Coordenação-Geral de Planejamento, Monitoramento e Controle Logístico
COEX	Coordenação de Demandas de Órgãos Externos de Vigilância em Saúde
DAF	Departamento de Assistência Farmacêutica
DJUD	Departamento de Gestão das Demandas em Judicialização na Saúde
DLOG	Departamento de Logística em Saúde
DPNI	Departamento do Programa Nacional de Imunizações
GM/MS	Gabinete do Ministro do Ministério da Saúde
IES	Insumos Estratégicos para a Saúde
MS	Ministério da Saúde
OMS	Organização Mundial de Saúde
OPAS	Organização Pan-Americana de Saúde
PEI/MS	Plano Estratégico Institucional

PGAIE	Projeto de Governança das Aquisições de Insumos Estratégicos
PNI	Programa Nacional de Imunizações
POP	Procedimento Operacional Padrão
RENAME	Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
SAES	Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
SE	Secretaria-Executiva
SECTICS	Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde
SEI	Sistema Eletrônico de Informações
SES	Secretaria de Estado de Saúde
SES/MG	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
SES/PB	Secretaria de Estado de Saúde da Paraíba
SESAB	Secretaria de Saúde do Estado da Bahia
SESA	Secretaria de Saúde do Paraná
SESAI	Secretaria de Saúde Indígena
SICLOM	Sistema de Controle Logístico de Medicamento
SIES	Sistema de Informação de Insumos Estratégicos
SISMAT	Sistema Integrado de Administração de Material
SVSA	Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente
SUS	Sistema Único de Saúde
TCU	Tribunal de Contas da União
VTCLOG	VOETUR Cargas e Encomendas LTDA

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 8

RESULTADOS DOS EXAMES 10

1. ENTENDIMENTO SOBRE FLUXO DE PLANEJAMENTO, AQUISIÇÃO E GESTÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 10

2. ANÁLISE SOBRE AS PERDAS EFETIVAS 12

3. ANÁLISE SOBRE AS PERDAS EM POTENCIAL 15

3.1. Destinação de IES após o vencimento da validade para entidade diferente de empresas que realizam o descarte 16

3.2. Destinação de IES para entidades voltadas a pesquisa científica e capacitações, caracterizando utilização dos insumos para fins não originalmente pretendidos ... 16

3.3. Destinação de IES próximo ao vencimento da validade e com prazo exíguo para utilização por entes subnacionais e instituições de saúde 17

4. PRINCIPAIS FATORES RELACIONADOS À OCORRÊNCIA DE PERDAS EFETIVAS E POTENCIAIS 21

4.1. Fatores relacionados a controles administrativos 22

4.1.1. Inexistência de parâmetros de aceitabilidade de perdas por parte do Ministério da Saúde. 22

4.1.2. Fragilidades nos controles sobre o montante de perdas físicas e técnicas de insumos de aquisição centralizada, ocorridas nos entes subnacionais. 27

4.1.3. Inadequações do Sistema SISMAT, registradas em relatórios anteriores da CGU e do TCU, com recomendação de substituição do sistema. 28

4.1.4. Descumprimento da Portaria GM/MS nº 4.777/2022, referente às ações para prevenção de perda de Insumos Estratégicos em Saúde. 30

4.1.5 Inadequações em termos e dispositivos da PORTARIA GM/MS nº 4.777/2022, que regula os procedimentos de planejamento, aquisição e gestão de IES. 32

4.2. Fatores relacionados à logística 34

4.2.1. Tempo de Transporte do Operador Logístico 34

4.2.2. Recebimento de insumos, no Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, com validade inferior a 70% do seu prazo de vida útil. 35

4.2.3. Ausência de critérios mínimos para recebimento de doações, tendo havido perdas de IES doados por decurso do prazo de validade.....37

RECOMENDAÇÕES.....40

CONCLUSÃO.....44

OS PRINCIPAIS FATORES RELACIONADOS À OCORRÊNCIA DE PERDAS EFETIVAS E POTENCIAIS DE IES FORAM: 44

INTRODUÇÃO

A Gestão de Insumos Estratégicos aplicados à Saúde (IES), é um macroprocesso gerido pelo Ministério da Saúde (MS), a partir da interação entre áreas específicas de sua estrutura, como a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde (SECTICS) e a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA) e a Secretaria Executiva, por meio do Departamento de Logística em Saúde (DLOG/SE/MS).

Trata-se de um objeto de grande relevância, uma vez que tem por objetivo garantir o acesso regular de medicamentos e insumos estratégicos para a saúde em tempo oportuno, em quantidade e qualidade adequadas e de forma vantajosa para a administração pública. A título de ilustração, entre as dez maiores aquisições de IES em 2023[1] constam itens como: vacinas (para gripe, HPV, Covid e meningite), insulina e anticoagulantes, além de medicamentos de alto custo como o Elexacaftor e o Nusinersena, que são fornecidos pelo SUS para o tratamento de bebês e crianças com fibrose cística[2] e atrofia muscular espinhal[3].

A gestão de IES pelo MS também merece atenção devido à sua materialidade. De acordo com as informações disponibilizadas nos relatórios de gestão do Ministério da Saúde referentes aos exercícios de 2021 a 2023, as aquisições de insumos estratégicos em saúde totalizaram R$ 62,9 bilhões. Mesmo que o volume de aquisições de R$ 30,7 bilhões registrado no exercício de 2021 tenha sido atípico devido às condições impostas pela pandemia de Covid-19, ainda assim as aquisições desse macroprocesso envolvem somas consideráveis, como as verificadas nos anos seguintes, sendo R$18,7 bilhões em 2022 e R$ 13,5 bilhões em 2023.

A complexidade do macroprocesso de gestão de insumos estratégicos é um fator a ser considerado quanto à criticidade, pelo risco inerente a etapas essenciais à sua operação, como o recebimento das demandas das secretarias finalísticas, a realização das licitações e das compras, a formalização dos contratos, o recebimento dos insumos e a gestão dos estoques e distribuição à rede SUS em todo o território nacional.

A criticidade do objeto em análise também foi evidenciada em trabalhos anteriores da CGU, que identificou inconsistências nos registros contábeis e em sistemas informatizados, como foi apresentado nas auditorias anuais de contas realizadas pela CGU relativas aos exercícios de 2021[4] e 2022[5], em reportagens sobre incineração de medicamentos e vacinas[6], fato

[1] Fonte: Relatório de Gestão do Ministério da Saúde 2023 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relatorio_Integral_gestao_tcu_MS_2023.pdf

[2]https://www.gov.br/conitec/pt-br/assuntos/noticias/2023/agosto/conitec-recomenda-incorporacao-de-medicamento-no-sus-que-pode-mudar-o-tratamento-da-fibrose-cistica-no-brasil

[3]https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2024/03/11/justica-manda-sus-fornecer-remedio-mais-caro-do-mundo-a-crianca-com-doenca-rara-em-al.ghtml

[4] https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/download/1020472

[5] https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/download/1296957

[6] https://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2023/04/18/exclusivo-relatorio-mostra-desperdicio-bilionario-de-insumos-no-ministerio-da-saude-desde-2019.ghtml; https://www.terra.com.br/economia/ministerio-da-

também mencionado em relatório produzido pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados[7].

Diante desses elementos, o tema foi priorizado pela CGU com o objetivo de identificar oportunidades de aprimoramento do processo. Para alcançar esse objetivo, foram propostas questões de auditoria que nortearam análises em torno dos seguintes tópicos:

1. Perdas efetivas de insumos estratégicos em estoque no Ministério da Saúde por vencimento da data de validade;
2. Perdas em potencial de insumos estratégicos por hipóteses de subdimensionamento; e
3. Principais fatores relacionados à ocorrência de perdas efetivas e em potencial.

Cabe registrar que a abordagem da auditoria não visou calcular prejuízos ou apontar responsabilidades, atendo-se a tratar de questões estruturantes, com o propósito de fomentar o aprimoramento do processo de gestão dos insumos estratégicos em saúde.

Os trabalhos foram realizados no período de maio de 2023 a junho de 2024 e abrangeram a movimentação de insumos pelo Ministério da Saúde no período de 2021 a 2023, a partir dos dados de sistemas corporativos do Ministério e do operador logístico contratado pelo órgão, que é a empresa Voetur Cargas e Encomendas Ltda (VTCLOG).

Além desta introdução, o presente relatório contempla, na seção “Resultados dos Exames”, um tópico inicial contendo breve descrição do fluxo operacional do macroprocesso sob exame e depois um registro para cada um dos pontos mencionados acima (perdas efetivas, perdas em potencial e fatores relacionados às perdas). Na sequência, apresenta as recomendações elaboradas em conjunto com os gestores para o aperfeiçoamento do processo e um tópico de conclusão com as considerações finais sobre o trabalho.

saude-teve-desperdicio-bilionario-com-remedios-e-vacinas-vencidos-nos-ultimos-anos,6bc88df03d0a94e70e27389e760e627113zyk45j.html

[7] Relatório da Visita Técnica da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle ao Almoxarifado VTCLOG em 14/4/2023.

RESULTADOS DOS EXAMES

1. Entendimento sobre fluxo de planejamento, aquisição e gestão de insumos estratégicos em saúde, no âmbito do Ministério da Saúde.

Conforme disposto no Plano Estratégico Institucional do Ministério da Saúde para o período de 2020 a 2023, a Cadeia de Valor do órgão é composta por seis macroprocessos finalísticos dentre os quais se encontra o de Gestão de Insumos Estratégicos aplicados à Saúde (IES).

O Relatório de Gestão do MS referente a 2021, em seu capítulo sobre Gestão de Riscos, traz a informação de que, à época, encontrava-se em execução o Projeto de Governança das Aquisições de Insumos Estratégicos (PGAIE), o qual tinha por objetivo aperfeiçoar o processo aquisitivo dos insumos estratégicos (medicamentos, vacinas e outro imunobiológicos) para assegurar, à população, o acesso regular a medicamentos de qualidade, em tempo oportuno, em quantidade adequada e de forma vantajosa para a administração.

As principais etapas do processo, bem como as principais áreas envolvidas, estão descritas de forma resumida a seguir[8].

Planejamento de demandas
Constitui-se no processo de elaboração do Plano de Contratações Anual, o qual contém todas as contratações pretendidas para o exercício subsequente e é disponibilizado pelo MS em transparência ativa no Portal Nacional de Contratações Públicas do Governo Federal[9]. Nesta fase os principais setores envolvidos são as Secretarias Finalísticas e o Departamento de Gestão das Demandas em Judicialização na Saúde, que descrevem as necessidades de insumos, e o DLOG, que consolida as demandas.

Planejamento de aquisições
Consiste no dimensionamento da demanda e na previsão da sistemática de entregas. A programação de medicamentos é um processo estratégico que visa planejar as quantidades a serem adquiridas, garantindo um abastecimento contínuo e evitando perdas decorrentes de aquisições excessivas. Essa programação é fortemente dependente da qualidade das informações provenientes da gestão de estoque, englobando a avaliação das necessidades por meio de dados históricos, a análise do estoque presente e de informações sobre distribuição, além de um monitoramento constante do consumo. Os principais envolvidos são as Secretarias Finalísticas (dimensionamento da demanda) e o DLOG (planejamento das licitações e compras).

Obtenção de insumos

[8] Informações produzidas com base na Portaria GM/MS nº 4.777/2022, em documentos relacionados ao PGAIE e em reuniões realizadas com as áreas do Ministério envolvidas no macroprocesso
[9] https://pncp.gov.br/app/pca?pagina=1&anos=2022%7C2023%7C2024&orgaos=46844

Trata-se do processo aquisitivo propriamente dito, que é conduzido pelo conduzido pelo DLOG e consiste na realização das licitações e atividades correlatas.

Gestão logística de IES

Envolve ações de controle de estoque, de distribuição, descarte[10] e gestão de contratos com empresas de logística e esta fase é especialmente importante, pois é nela que podem ser adotadas providências vinculadas à prevenção de perdas, tais como: supressão unilateral nas compras, cancelando as entregas que ainda não tiverem sido feitas; substituição do medicamento com validade próxima a expirar, nos casos em que o fornecimento tiver previsão desse tipo de mecanismo (carta de troca); propostas de alteração da forma de utilização do insumo em risco; extensão da validade; utilização para outros fins não previstos inicialmente, como pesquisas científicas; e doação do insumo estratégico próximo ao vencimento. A responsabilidade pela gestão dos insumos estratégicos em saúde armazenados no Centro de Distribuição (localizado em Guarulhos/SP) é compartilhada entre o DLOG e os requisitantes[11]. Esta etapa conta com a participação das Secretarias Finalísticas, do DLOG e do operador logístico contratado pelo Ministério da Saúde (VTCLOG - VOETUR Cargas e Encomendas LTDA)

Feitas as contextualizações gerais do trabalho e do entendimento do macroprocesso analisado, o relatório passa a apresentar os resultados dos exames.

[10] Os descartes por incineração contabilizados pelo Ministério da Saúde dizem respeito apenas aos insumos perdidos dentro do próprio Centro de Distribuição do Ministério da Saúde. Conforme esclarecido pela SVSA, o Ministério não realiza o recolhimento das doses de vacinas expiradas nos Estados para fins de descarte.

[11] Portaria GM/MS Nº 4.777/2022 – Capítulo III - DA GESTÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE.

2. Análise sobre as perdas efetivas

Este tópico tem a finalidade de analisar de forma descritiva a composição das perdas de insumos ocorridas entre 2021 e 2023. Para fins da presente análise, os insumos foram classificados em três categorias distintas, em função da previsibilidade de sua utilização:

- Covid-19: Trata-se da categoria com menor previsibilidade quanto à sua utilização e perda, devido à situação atípica da pandemia. Consiste em insumos adquiridos por compra ou doação para enfrentamento da emergência, tais como vacinas, roupas de proteção, máscaras, analgésicos, sedativos, entre outros;
- Demandas judiciais: Como o nome indica, trata-se da categoria composta pelos insumos adquiridos pelo Ministério da Saúde em atendimento a determinações do Poder Judiciário. Embora seja possível fazer alguma estimativa com base em série histórica, ainda assim é considerada uma categoria de previsibilidade baixa e, portanto, sujeita a um grau também menos presumível de utilização e perdas;
- Demais insumos: É a categoria composta pelos demais itens, quais sejam, aqueles comumente adquiridos pelo Ministério da Saúde. Entre os três grupos, é considerado o de maior grau de previsibilidade quanto ao consumo e às perdas.

Os números relativos a cada uma dessas categorias estão detalhados na tabela abaixo, juntamente com os valores dos estoques totais ao final de cada exercício, o que permite calcular o percentual de perda efetiva em cada um dos exercícios analisados.

Tabela 1 Perdas efetivas por categoria e por ano (valores em R$ milhões)

Categorias	2021	2022	2023	Total
Covid (A)	37,1	445,8	1.593,3	2.076,3
Demandas judiciais (B)	6,6	4,0	13,5	24,2
Demais insumos (C)	9,1	92,4	111,4	213,0

Fonte: Elaboração própria a partir de informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde

Ao aprofundar o detalhamento na categoria de insumos relacionados à Covid-19[12], do total de R$ 2.076.391.671,36 em valor de insumos descartados, constatou-se que R$ 1.579.128.073,77 (76,1%) corresponderam a vacinas contra Sars-Cov-2; R$ 317.264.127,31 (15,3%) a anestésicos, medicamentos e insumos para Intubação Orotraqueal (IOT); e R$ 179.999.470,27 (8,7%) a itens de vestuário como roupas de proteção e máscaras.

Especificamente quanto aos insumos relacionados à pandemia de Covid-19, cabe destacar que o caráter altamente imprevisível da pandemia e a incerteza em relação ao seu desfecho exigiram que o MS se preparasse para uma situação sem precedentes, onde a demanda por insumos essenciais de intubação e vestuário disparava de maneira abrupta e inesperada. Antes do desenvolvimento e ampla distribuição da vacina, havia uma nítida necessidade de adquirir a primeira vacina que se tornasse disponível no mercado em quantidades suficientes

[12] Matéria também abordada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) nos acórdãos nº 313/2023 e 2123/2023.

para imunizar toda a população, uma vez que ela era vista como o principal insumo capaz de dar fim à pandemia e ao isolamento social.

Desse modo, é fundamental reconhecer que o contexto de imprevisibilidade, alta incerteza e a rápida evolução da situação pandêmica acabaram por gerar perdas de insumos que escaparam a um planejamento prévio. Tais situações, inerente à pandemia, dificultaram a implementação de estratégias eficazes para mitigar essas perdas, evidenciando a necessidade de um aprimoramento contínuo nas práticas de gestão de insumos em emergências de saúde pública.

Quanto ao valor de R$ 24.251.462,78 dos insumos relacionados a demandas judiciais, R$ 19.151.992,94 (ou 78,9%) remetem a insumos que foram devolvidos ao Ministério da Saúde, pelo paciente e/ou ente subnacional. Em visita técnica ao Centro de Distribuição do MS em Guarulhos/SP, a equipe de auditoria constatou que os insumos devolvidos nesta condição ficam recolhidos em uma área segregada do almoxarifado com acesso restrito enquanto aguardam autorização para descarte.

Por fim, no grupo de demais insumos (excluídos os fatores pandemia e demandas judiciais), o valor de R$ 213.071.944,17 refere-se a 125 insumos distintos. A importância da análise sobre este grupo reside no fato de ser o segmento que engloba os insumos mais típicos do macroprocesso e, portanto, sujeito a maior previsibilidade em sua gestão. Os valores relativos a este grupo estão divididos por quantidade de insumos e valor financeiro agregado entre quatro Secretarias Finalísticas do Ministério, da seguinte forma:

Tabela 2 Quantidade de insumos distintos descartados por secretaria requisitante de IES

Secretaria	Insumos	Valor total de insumos
SVSA	67	170.568.801,40
SECTICS	48	42.117.328,03
SESAI	8	339.562,52
SAES	2	46.252,22
Total	**125**	**213.071.944,17**

Fonte: Elaboração própria a partir de informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde

As maiores quantidades de insumos são geridas pela SVSA e SECTICS e refletem competências dessas duas secretarias enquanto unidades responsáveis por programas de saúde de abrangência nacional, como o Programa Nacional de Imunizações e a Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos, respectivamente (Decreto 11.798/2023).

A fim de proporcionar uma visão mais detalhada sobre os itens que compõem os valores acima, as tabelas a seguir apresentam os dez insumos descartados de maior valor financeiro agregado e os dez insumos descartados em maior quantidade agregada[13] [14].

[13] O mesmo insumo pode ter vários lotes diferentes descartados ao longo de um período. A primeira tabela representa os insumos descartados de maior valor financeiro, e a segunda tabela representa os insumos que foram mais descartados em termos de quantidade.

[14] A lista completa das tabelas 2 e 3 está disponível em anexo neste relatório

Tabela 3 - Os dez insumos de maior valor financeiro agregado destinados ao descarte no período de 01.01.2021 a 31.12.2023

Insumo descartado	Secretaria	Quantidade	Valor (R$)
Vacina Contra Raiva Cultura Celular - 1 dose	SVSA	522.648	38.623.687,20
Vacina Dupla Viral (sarampo e rubéola) 10 doses	SVSA	1.015.908	28.695.792,10
Vacina Menigocócica C Conjugada - Frasco	SVSA	344.498	16.238.391,10
Vacina contra Febre Amarela - 5 doses	SVSA	578.256	11.908.096,24
Vacina contra Raiva - 1 dose (diluente separado)	SVSA	256.754	11.335.179,90
Vacina Tríplice (DTP) 10 doses	SVSA	866.993	9.915.217,68
Vacina Tríplice Viral 5 doses	SVSA	321.284	9.855.907,84
Imunoglobulina Anti-Hepatite B 1000UI/5ml (ampola)	SVSA	7.103	6.185.517,00
Total SVSA	**-**	***3.913.444***	***132.757.789,06***
Insulina Análoga de ação rápida100UI/ml inj.3ml	SECTICS	885.885	13.215.868,66
Alfapeinterferona 2A 180 mcg	SECTICS	19.315	11.675.966,31
Total SECTICS	**-**	***905.200***	***24.891.834,97***
Total	**-**	**4.818.644**	**157.649.624,03**

Fonte: Elaboração própria a partir de informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde

Tabela 4 - Os dez insumos de maior quantidade agregada destinados ao descarte no período de 01,01.2021 a 31.12.2023

Insumo descartado	Secretaria	Valor (R$)	Quantidade
Seringa estéril descartável 0,1 ml c/ agulha 27x38	SVSA	3.922.020,29	14.007.200
Bula Vacina Tríplice Viral	SVSA	51,90	5.190.310
Vacina Dupla Viral (Sarampo e Rubéola) 10 doses	SVSA	28.695.792,10	1.015.908
Vacina Tríplice (DTP) 10 doses	SVSA	9.915.217,68	866.993
Vacina contra Febre Amarela 5 doses	SVSA	11.908.096,24	578.256
Vacina contra Raiva cultura celular 1 dose	SVSA	38.623.687,20	522.648
Total SVSA		***93.064.865,41***	***22.181.315***
Levonorgestrel 0,15 + Etinilestradiol 0,03 compr.	SECTICS	3.321.296,75	84.830.256
Acetato de Demopressina 0,1mg compr.	SECTICS	2.886.653,68	2.745.600
Acetato de Demopressina 0,2mg	SECTICS	2.876.217,15	1.444.650
Insulina análoga ação rápida 100UI/ml inj. 3ml	SECTICS	13.215.868,66	885.885
Total SECTICS		***22.300.036,24***	***89.906.391***
Total Geral	**-**	**115.364.901,65**	**112.087.706**

Fonte: Elaboração própria a partir de informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde

Retomando-se os dados da Tabela 3, nota-se que, no período examinado, a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA) foi a unidade do Ministério que descartou a maior quantidade de insumos diferentes (67) e de maior representatividade financeira, no montante de R$ 170 milhões, correspondendo a 80% dos descartes de todos os insumos comumente adquiridos pelo MS no período (R$ 213 milhões). Por sua vez, as vacinas correspondem a 31 desses 67 insumos, com um valor total descartado de R$ 149 milhões.

Cumpre ressaltar que, das dez vacinas mais descartadas no período, oito delas fazem parte do calendário básico de vacinação do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério, conforme se depreende da tabela a seguir:

Tabela 5 - As dez vacinas com maior quantitativo de descarte no Centro de Distribuição do Ministério da Saúde no período de 01.01.2021 a 31.12.2023

Insumo descartado (somente vacina)	Calendário Básico	Valor (R$)	Quantidade
Vacina Dupla Viral (sarampo e rubéola) 10 doses	Sim	28.695.792.10	1.015.908
Vacina Tríplice (DTP) 10 doses	Sim	9.915.217,68	866.993
Vacina contra Febre Amarela - 5 doses	Sim	11.908.096,24	578.256
Vacina Menigocócica C Conjugada – Frasco	Sim	16.238.391,10	344.498
Vacina Tríplice Viral 5 doses	Sim	9.855.907,84	321.284
Vacina BCG intradérmico 20 doses	Sim	3.416.409,48	252.169
Vacina Pentavalente 1 dose	Sim	1.078.036,54	241.778
Vacina Tríplice Viral (TVV) 10 doses	Sim	6.060.028,10	59.481
Subtotal Calendário Básico (Sim)		***87.167.879,08***	***3.680.367***
Vacina contra Raiva Cultura Celular - 1 dose	Não	38.623.687,20	522.648
Vacina contra Raiva - 1 dose (diluente separado)	Não	11.335.179,90	256.754
Subtotal Calendário Básico (Não)		***49.958.867,10***	***779.408***
Total Geral	**-**	**137.126.746,18**	**4.459.769**

Fonte: Elaboração própria a partir de informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde

Como se observa na tabela acima, das dez vacinas com maior quantitativo de descarte nos exercícios de 2021 a 2023, duas delas (*vacina contra raiva* e *vacina contra a raiva com diluente separado*), não constam no calendário básico de vacinação por serem insumos utilizados apenas em caso de incidentes envolvendo animais. As demais são insumos que fazem parte do calendário básico do Plano Nacional de Imunização (PNI), cujo perfil de consumo é mais previsível e, portanto, sujeito a controles que possam minimizar as perdas.

Por fim, cabe mencionar que esses valores dizem respeito apenas aos insumos destinados ao descarte dentro do próprio Centro de Distribuição do Ministério da Saúde. Conforme esclarecido pela SVSA[15], o Ministério não realiza o recolhimento das doses de vacinas expiradas nos Estados para fins de descarte, uma vez que, após recebidos pelos Estados, os insumos se tornam responsabilidade da sua gestão, fazendo com que eventuais perdas por vencimento da validade sejam geridas e descartadas pelos próprios entes.

3. Análise sobre as perdas em potencial

Além das perdas efetivas tratadas no tópico anterior, há outras situações que podem caracterizar perda potencial de insumos. Conforme tratado em parte específica deste relatório, as diretrizes e normas vigentes não definem de forma objetiva o conceito de perda de insumos estratégicos em saúde. Também se evidenciou a necessidade de se definirem parâmetros e procedimentos formalizados para identificação e registro dessas perdas, de maneira a distinguir situações de saídas de estoque para consumo das saídas por perdas[16], conforme já tratado nas Auditorias Anuais de Contas referentes aos exercícios de 2020 e 2021.

[15] Fonte: Despacho CGGI/DPNI/SVSA/MS, presente no OFÍCIO Nº 1472/2023/CGINTE/AECI/MS.

[16] AAC 2020 – Relatório de Auditoria nº 879316 – Item 2.3.2; AAC 2021 – Relatório de Auditoria nº 1016345 – Item 2.3.4.

Com o intuito de refinar o escopo dos exames desta seção, foram feitas análises nos dados de saída de Insumos Estratégicos em Saúde (IES) do Sistema Integrado de Administração de Material do MS (SISMAT), e do Portal do Operador Logístico Voetur Cargas e Encomendas LTDA (VTCLOG) no período de 2021 a 2023, para identificar os insumos que não tenham sido destinados ao processo de descarte e, consequentemente, não estão contidos nas perdas calculadas na seção anterior deste relatório.

Com base nesses elementos, as análises deste tópico tiveram por objetivo trazer subsídios para discussões com a gestão sobre os riscos de materialização dessas hipóteses, bem como as medidas necessárias para seu controle. Portanto os números apresentados não indicam perdas necessariamente concretizadas, mas os montantes sobre os quais incidiram os riscos, por isso denominadas neste relatório como *perda potencial*.

3.1. Destinação de IES após o vencimento da validade para entidade diferente de empresas que realizam o descarte

Entre 2021 e 2023 identificou-se um total de saídas de mais de 28 milhões de itens de IES vencidos do Centro de Distribuição para entidades diferentes de empresas que realizam o descarte, correspondendo a um valor de aproximadamente R$ 246 milhões. Essas saídas tiveram como destinatários fabricantes, fornecedores, instituições de saúde, entre outros. A maioria significativa, representando 99,45% dos insumos vencidos, foi direcionada a empresas fornecedoras e fabricantes da indústria farmacêutica. Hospitais e secretarias municipais de saúde foram os destinatários da quantidade residual, correspondente a 0,55%.

Nas oportunidades de interação ao longo da execução da auditoria, o Ministério da Saúde não aportou suas considerações especificamente sobre as saídas relacionadas acima, como por exemplo, se há condição contratual para a reposição dos insumos com ônus para a empresa fornecedora, ou sobre os instrumentos que fundamentam a saída de insumos vencidos para hospitais e secretarias municipais de saúde.

Com base nas informações até aqui coletadas, não foi possível afastar a hipótese de que os insumos destinados a empresas e instituições de saúde examinados neste subtópico representem uma subestimação inadequada das perdas por expiração do prazo de validade no valor de R$ 246.722.585,36.

3.2. Destinação de IES para entidades voltadas a pesquisa científica e capacitações, caracterizando utilização dos insumos para fins não originalmente pretendidos

Outra hipótese de subestimação de perdas consiste na situação identificada em que foi feito o envio de IES para serem usados em pesquisas e treinamentos. Embora não seja necessariamente perda por descarte, o fato caracterizaria, em princípio, uso em finalidade diferente da originalmente prevista. As ocorrências foram detectadas por meio da aplicação de filtros nos dados de saída de insumos, no período compreendido entre 2021 e 2023, focando em destinatários associados a atividades de pesquisa, como faculdades, universidades e fundações.

Após análise das observações do Ministério da Saúde sobre essa situação e, excluindo-se as saídas que não se aplicavam ao caso sob exame, verificou-se um total de saídas de 744.175 unidades de IES do Centro de Distribuição para entidades de pesquisa, correspondendo a um montante de R$ 278 milhões.

Das análises realizadas, também foi possível verificar que os insumos foram enviados para cerca de 140 entidades distintas, todas em alguma medida vinculadas a atividades de pesquisas em saúde, como por exemplo, a Fundação Osvaldo Cruz e o Instituto Vital Brazil, que receberam respectivamente 61,7% e 10,8% dos insumos computados nessa categoria.

Há que se registrar que a Portaria GM/MS nº 4.777, trata da possibilidade de utilização de insumos para outros fins não previstos inicialmente como uma medida preventiva possível a ser adotada para insumos que adentrem em período crítico de vencimento, que é de 240 dias para o fim da validade.

Contudo, a falta de uma normatização objetiva a respeito do conceito de perda de insumos resulta em imprecisão do que é registrado como perda e como consumo. Tal situação pode fazer com que saídas alternativas, como pesquisas e treinamentos, podem ter sido erroneamente contabilizadas como consumo, distorcendo as estimativas para futuras aquisições, sobretudo em programações baseadas no método de consumo histórico.

Assim, considerando que os insumos destinados a essas instituições serviram para pesquisas e treinamentos, não foi possível, com base nas informações obtidas durante a execução do trabalho, afastar a hipótese de que essa não tenha sido a utilização originalmente prevista e, portanto, representem uma subestimação inadequada das perdas no montante de R$278 milhões.

3.3. Destinação de IES próximo ao vencimento da validade e com prazo exíguo para utilização por entes subnacionais e instituições de saúde

Para melhor compreensão desta categoria, que é a mais representativa das saídas analisadas, com 41,6 milhões de unidades e com valor estimado em R$4,4 bilhões, buscou-se identificar critérios que fossem os mais objetivos e aplicáveis ao caso. Contudo, o que se verificou foi que o arcabouço técnico e normativo vigente não oferece as condições necessárias para análises no nível de detalhamento pretendido. Isso porque, quanto ao prazo de vida útil dos insumos, não foram identificados parâmetros de prazo de validade mínima para distribuição de IES a entes subnacionais, restando como critério geral a Portaria GM/MS Nº 4.777, estabelecendo que insumos a 240 dias do vencimento já entram no período crítico para perda da validade.

Diante dessas circunstâncias, optou-se por um critério mais conservador para os exames que serão apresentados a seguir. O escopo se restringiu aos insumos com validade entre 1 e 90 dias que saíram do depósito localizado no município de Guarulhos/SP, no período de 2021 a 2023. Esse recorte representa o montante de R$ 4.464.652.043,48, não fazendo distinção aqui quanto as três categorias de análise: Covid-19, Demandas Judiciais e Demais Insumos. Os resultados são apresentados a seguir, por faixa de prazos de validade, realizados a partir de análises nos dados de saída de IES do SISMAT e do Portal do Operador Logístico VTCLOG.

Os insumos com vencimento entre 1 e 14 dias distribuídos entre os exercícios de 2021 e 2023 abrangeram a quantidade de 1.467.444 unidades, e corresponderam a um montante de R$287.334.043,41. Como esses insumos foram distribuídos pelo Ministério da Saúde com a finalidade de consumo ordinário, depreende-se que não foram registrados internamente como perda.

Contudo, há que se considerar o tempo logístico exigido desde a saída do Centro de Distribuição do Ministério da Saúde em Guarulhos/SP, até a chegada ao usuário final. Sabe-se que esse percurso inclui diversas etapas, como transporte, passagem por almoxarifados estaduais, Unidades Regionais de Saúde, almoxarifados municipais, distribuição para estabelecimentos de saúde e, por fim, a dispensação ou uso pelo paciente/usuário final. Assim, diante desse contexto, é razoável inferir que os insumos distribuídos entre 1 e 14 dias para o fim da validade não puderam ser utilizados a tempo, daí seu cômputo neste relatório no total de perdas em potencial.

Os insumos distribuídos entre 15 e 90 dias, entre os exercícios de 2021 e 2023, totalizaram 40.221.365 unidades e corresponderam a um montante de R$4.177.318.000,08.

Devido aos desafios logísticos já mencionados, entendeu-se inicialmente que a distribuição de insumos no prazo entre 15 e 90 dias para o fim da validade também seria exíguo, e que os produtos estariam sujeitos a um risco elevado de perda após a distribuição.

Para averiguar se esse entendimento era pertinente, foram realizados dois grupos de testes: consulta a SES e análise dos dados sobre estoques nos municípios

3.3.1. Consultas às SES

Seis Secretarias Estaduais de Saúde (SES), de estados com diferentes peculiaridades logísticas, foram consultadas sobre o tema[17]. Buscou-se esclarecimento sobre exigência de prazo mínimo de validade no momento do recebimento de insumos; existência de fluxos relativos ao recolhimento ou descarte de insumos vencidos, bem como fluxos de retroalimentação de informações sobre perdas de insumos ao Ministério da Saúde.

Em síntese, a manifestação dos estados corroborou a hipótese de que há perdas consideráveis nos insumos recebidos com prazo de validade entre 15 e 90 dias de vida útil restante. As respostas indicaram que parcelas dos produtos foram descartadas, outras foram distribuídas, recolhidas pelo Ministério da Saúde, ou submetidas a extensões de validade para aproveitamento. As respostas trouxeram ainda que as secretarias estaduais não dispõem de informações sobre a destinação final de itens distribuídos aos municípios. Isso ocorre porque as SES representam apenas uma etapa da cadeia logística de distribuição dos insumos provenientes do Ministério da Saúde, não se constituindo no destinatário final. A manifestação dos estados também indicou que a lacuna de normativos e estudos sobre prazos mínimos também ocorre no contexto local. Tais estudos e normativos com recortes locais

[17] Bahia, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná e Rio Grande do Sul.

seriam úteis para a gestão dos insumos pelo ministério, pois é natural supor que, um estado com menor extensão territorial, por exemplo, consiga trabalhar com prazos que seriam inviáveis em estados maiores.

A interação com as secretarias estaduais indica que as discussões sobre o tema não são recentes, tendo sido pauta de documentos e de reuniões presenciais e online. Há menção a ocasiões em que foi sugerido que o prazo de validade deveria ser de pelo menos 90 dias, a partir da data de recebimento, visando minimizar o risco de perda de insumos por validade. Houve referências também a situações específicas quando da distribuição de testes rápidos para a Covid-19 próximos do vencimento. Uma das secretarias consultadas trouxe uma estimativa mais detalhada dos prazos viáveis nos seus estados para itens que dependem de refrigeração, como, por exemplo as vacinas. Nesse estado específico, seriam 50 dias entre a saída do centro de distribuição do MS até a chegada nos municípios, sem levar em consideração o tempo para utilização nas salas de vacina.

Se pelo lado do envio não há definição de prazo mínimo, a consulta aos estados questionou se há regras ou parâmetros por parte das SES quanto ao prazo mínimo de validade no recebimento. Sobre esse ponto, o que se depreende das respostas é que seria inviável aos estados e municípios recusar insumos próximos do vencimento, devido ao risco de desabastecimento (e todos os seus impactos). Assim, os entes recebedores arcam com o custo de ter que acelerar suas operações logísticas para utilizar a quantidade que for possível antes do vencimento.

Quanto à destinação dos itens vencidos, as secretarias consultadas informaram que realizam os descartes de insumos, a menos que haja *Carta de Troca*. Nesses casos, o Ministério da Saúde ou o fornecedor procedem à coleta para recolhimento dos insumos.

Quanto aos fluxos de retroalimentação de informações sobre perdas de insumos ao Ministério da Saúde, houve manifestação de que uma SES registra as perdas no SIES e SICLOM[18] para insumos vinculados à SVSA, porém para outros insumos isso não é feito, uma vez que ainda não há procedimento ou sistema para comunicar tais vencimentos. Tal fato é corroborado por um dos gestores estaduais consultados, que informou não haver sistemas, fluxos e procedimentos relativos à comunicação para recolhimento dos insumos elencados na auditoria em questão", e por outro ainda, que informou repassar informações de perda ao Ministério da Saúde por e-mail ou Ofício, somente quando julga pertinente.

As manifestações trazidas pelas Secretarias Estaduais de Saúde evidenciam a oportunidade de aperfeiçoamento em normativos e fluxos quanto à distribuição de insumos com vencimento abaixo de 240 dias, bem como em rotinas de reuniões entre o ministério e as secretarias para a busca de entendimentos e deliberações sobre o tema.

[18] SIES – Sistema de Informação de Insumos; SICLOM – Sistema de Controle Logístico de Medicamento – ambos vinculados somente a insumos da SVSA.

3.3.2. Estoques nos estados e municípios de acordo com os dados da BNAFAR e SIES

Além da manifestação dos estados, foram feitos exames complementares para subsidiar as conclusões sobre o potencial de perdas por vencimento após a saída dos insumos do Centro de Distribuição e, consequentemente, o subdimensionamento dessas perdas. Desses exames, destacam-se as seguintes situações descritas a seguir.

Outro exame realizado consistiu em se verificar em que medida os estados e municípios conseguem utilizar os produtos recebidos antes de seu vencimento, considerando as constatações anteriormente mencionadas. Para essa finalidade, recorreu-se a análises em duas fontes de dados sobre o tema: a Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica no SUS (BNAFAR) e o Sistema de Informação de Insumos Estratégicos (SIES). O BNAFAR é a base alimentada por Municípios, Estados e Distrito Federal que consolida os dados nacionais de posição de estoque, entradas, saídas, avaliações e dispensações realizadas pelos estabelecimentos de saúde dos para os medicamentos padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) e do Programa Farmácia Popular. O SIES é alimentado por municípios, estados e o Distrito Federal, com dados de insumos associados à Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (que não estão incluídos na BNAFAR).

A análise do BNAFAR foi realizada a partir de uma ferramenta de *Business Intelligence* desenvolvida pelo Ministério da Saúde e, a partir de consultas feitas na mencionada ferramenta, verificou-se que há um volume considerável registros indicando produtos com o prazo de validade vencido nos estoques de estados e municípios e no Distrito Federal. Por exemplo, um relatório pontual armazenado na ferramenta com data de 10.01.2023, referente ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, que detalha produtos do Grupo 1A[19] indicava que 308.565 insumos estavam vencidos, correspondendo a um valor de R$ 11.394.568,66 (com a ressalva de que o valor de 40 insumos estava zerado na planilha exportada).

Outra consulta realizada na plataforma, dessa vez comparando o estoque total e o estoque de insumos vencidos, também corroborou a situação mencionada no parágrafo anterior, indicando uma proporção elevada de insumos vencidos nos estoques de estados e municípios. Verificou-se ainda uma divisão na origem das informações: parte das unidades da federação utiliza o sistema Hórus e outra parte utiliza o BNAFAR por meio de Web Service. A menção a esse fato é necessária, pois a proporção de insumos vencidos na base do BNAFAR é maior do que a verificada no Hórus, o que pode indicar alguma inconsistência nos dados ou no fluxo de informações.

Quanto ao SIES, as consultas realizadas também indicaram volumes consideráveis de perdas nos estoques subnacionais. O relatório *Mapa de Saída por Perdas por Validade Vencida*, para imunobiológicos, no período entre 2021 e 2023, evidencia a perda de 81.141.422 doses de

[19] O Grupo 1ª é composto pelos medicamentos cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde e a responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação, é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. (https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sectics/daf/ceaf/grupos-de-medicamentos).

imunobiológicos, incluindo vacinas, soros e imunoglobulinas, correspondendo a um montante de R$ 1.479.742.666,60.

A SVSA, secretaria do Ministério da Saúde vinculada aos insumos geridos pelo SIES, informou que o Ministério não realiza o recolhimento das doses expiradas nos estados e municípios, em caso de expiração da validade, uma vez que a responsabilidade de gestão dos insumos após o recebimento é dos Estados, conforme estabelece a Portaria de Consolidação nº 4. Com isso, considerando que a principal fonte de informação do Ministério da Saúde sobre perdas dos insumos é o SIES, cuja alimentação é feita por estados e municípios, e considerando que não foram feitos testes específicos nos estados e municípios sobre a consistência desses dados, o montante indicado no parágrafo anterior foi incluído no cômputo das perdas em potencial.

Essas informações indicam a necessidade de aperfeiçoamento nas orientações e práticas associadas à utilização desses dois sistemas, devido à importância da qualidade dos dados para que se estimem corretamente os quantitativos de insumos utilizados e eventualmente perdidos, possibilitando uma gestão mais eficiente desses recursos.

Em síntese, este tópico, que tratou das perdas em potencial, trouxe as seguintes constatações: a) destinações de IES após o vencimento da validade para entidade diferente de empresas que realizam o descarte, no montante de R$ 246.722585,36, não dimensionadas como perda; b) destinações de IES para entidades voltadas a pesquisa científica e capacitações, no montante de R$ 278.273.026,52 em detrimento da utilização para os fins originalmente previstos e não dimensionadas como perda; c) destinações a estados e municípios de IES próximas do vencimento da validade no montante de R$ 4.464.652.043,48, incorrendo em risco substancial de perdas.

Essas constatações fundamentam as seguintes conclusões: a) necessidade de rever os normativos e procedimentos relacionados à destinação e adequado registro de IES para finalidades distintas das originalmente previstas; b) necessidade de testes para aferir a qualidade dos dados do BNAFAR e SIES; c) necessidade de aprimoramento nos normativos e fluxos quanto à distribuição de insumos com vencimento abaixo de 240 dias; d) aperfeiçoamento nas rotinas de reuniões entre o ministério e as secretarias para a busca de entendimentos e deliberações sobre o tema.

Com base nas constatações e conclusões deste tópico 3 sobre perdas em potencial, bem como nas análises das perdas efetivas, tratadas no tópico 2, o relatório passa a tratar dos principais fatores que podem estar relacionados à ocorrência dessas perdas.

4. Principais fatores relacionados à ocorrência de perdas efetivas e potenciais

Nos tópicos iniciais deste relatório foi evidenciada a complexidade e a dimensão do macroprocesso de gestão de insumos estratégicos em saúde. Realizar a gestão desse macroprocesso em um país com as características do Brasil, com sua dimensão territorial, suas desigualdades regionais, seu arranjo federativo, seu arcabouço legal e administrativo é um

desafio incontestável. Isso também implica em reconhecer que é da natureza das atividades logísticas que perdas e descartes ocorram em alguma medida.

Contudo, como as quantidades e cifras envolvidas nesse processo são elevadas, é crucial que todas as oportunidades viáveis de redução de perdas sejam aproveitadas, seja pela qualidade do gasto, pela relevância social, seja pelo argumento da garantia da integridade do macroprocesso, proporcionando aos servidores, fornecedores e gestores estaduais e municipais a menor exposição possível a riscos dessa natureza e todas as suas consequências.

Assim, esta parte do relatório apresenta análises realizadas sobre fatores que merecem debate e aprimoramento, pelo potencial de impacto nas perdas efetivas e potenciais, agrupados em duas categorias de análise: *controles administrativos* e *logística*.

4.1. Fatores relacionados a controles administrativos

4.1.1. Inexistência de parâmetros de aceitabilidade de perdas por parte do Ministério da Saúde.

É importante mencionar que a existência de perdas não significa necessariamente ineficiência na gestão dos insumos de saúde. Nesse sentido, é legítimo que haja um quantitativo de perda esperado e controlado, como, por exemplo, em situações de tratamento de segunda linha em que os insumos precisam estar disponíveis para pacientes que não respondem aos medicamentos mais usuais.

Referenciais da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS)[20] [21] [22] sugerem um limite de perda aceitável de até 1% do quantitativo total de insumos adquiridos, mas é possível encontrar referências que mencionam de 3% a 5%[23] como um limite de perda tolerável. O importante é que seja estabelecida uma referência de perda máxima que sirva para balizar indicadores e metas a serem seguidas para o aprimoramento da gestão e a redução das perdas.

Do que foi possível apurar junto às áreas que gerenciam os maiores volumes e recursos de insumos estratégicos em saúde, não há limites ou parâmetros estabelecidos institucionalmente para perdas no âmbito do Ministério da Saúde. Na ausência de um parâmetro próprio do ministério, questionou-se junto às áreas envolvidas se o limite de 1% encontrado nos referenciais da OPAS/OMS seria uma referencial plausível. As manifestações sobre essa sugestão, todavia, não responderam objetivamente a pergunta e foram no sentido

[20] Vaccine Stock management - OMS - Setembro/2006 - Pg 33.
[21] Harmonized monitoring and evaluation indicators for procurement and supply management systems - OMS - 2011 - Pg 9, 25 e 26.
[22] A Practical Guide For Procurement Planning And Management Of Strategic Public Health Supplies - OPAS - 2006 - Pg 48.
[23] A retrospective review of vaccine wastage and associated risk factors in the Littoral region of Cameroon during 2016–2017.

de que não há obrigatoriedade de adoção de parâmetros definidos por organismos internacionais.

Entretanto, ressalte-se que a ausência de norma determinando um percentual aceitável de perda não significa que os países não devam estabelecer seus próprios parâmetros. Desse modo, é razoável pensar, por exemplo, em um índice geral, agregando índices próprios de acordo com categorias específicas de insumos. Exemplificativamente, pode ser desejável que um insumo como o soro antiofídico possua um maior percentual de perda aceitável por refletir uma baixa probabilidade de necessidade do insumo, resultante de poucos casos de acidentes com serpentes na população geral, contudo com um alto impacto para morbidade e letalidade dos acometidos; ou que um insumo utilizado no tratamento de diabetes ou hipertensão arterial possua menor percentual de perda aceitável por se tratar de um medicamento de demanda constante pela população. Ademais, os percentuais de perda registrados em série histórica poderiam ser usados também para refletir a condição da saúde pública do país e nortear o planejamento das ações do poder público.

Nesse sentido, o Ministério da Saúde, unidade gestora e detentora do conhecimento técnico, tem as competências necessárias para definir quais insumos podem tolerar uma perda percentualmente maior sem comprometer a eficácia e a qualidade dos serviços de saúde prestados à população. Ao estabelecer parâmetros de perda aceitáveis, adaptados a cada insumo ou tipo de insumo, o Ministério pode planejar melhor a alocação de recursos no âmbito das políticas públicas de saúde e até mesmo justificar apropriadamente eventuais perdas futuras de IES de acordo com esses parâmetros.

Dos exames realizados, também foi possível constatar a inexistência de parâmetros estabelecidos para os diferentes tipos de perdas de IES no Centro de Distribuição em Guarulhos (como por exemplo perda por decurso do prazo de validade, por avaria, por extravio, por expedição inadequada etc.). Um documento técnico que descrevesse tipologias de perdas já teria o potencial de auxiliar o Ministério na identificação e mensuração das perdas que ocorrem dentro do Centro de Distribuição, visando atuar de maneira corretiva sobre as causas dessas perdas e minimizando desperdícios e tornando mais eficiente a gestão do contrato com a empresa de logística que opera o Centro de Distribuição. Com uma compreensão mais sistematizada dos riscos, causas e consequências das perdas de insumos, o Ministério poderia implementar medidas proativas para mitigar esses problemas, como melhorias nos processos de armazenamento e transporte, revisão das práticas de expedição e investimento em tecnologia para monitoramento e rastreamento dos insumos, bem como medidas de responsabilização mais efetivas quando a perda ocorrer por falhas evitáveis ou por irregularidades nas operações.

Não obstante o Ministério da Saúde não definir parâmetros de perdas aceitáveis, e objetivando estimar o atual percentual de perdas de diferentes áreas do Ministério da Saúde, analisou-se uma amostra extraída do montante destinado ao descarte dos insumos da

Categoria 3[24], a partir dos registros de entradas constantes do SISMAT[25], referentes aos quantitativos adquiridos dos respectivos insumos no período de 2018 a 2022, o que resultou no universo amostral de R$ 213.071.944,17.

Quanto à metodologia, a amostra não probabilística de itens foi selecionada de modo a representar pelo menos 90% da quantidade total de itens descartados no universo amostral. Começando pelos insumos com maior quantidade de itens descartados, foram adicionados outros insumos, sequencialmente, até atingir ou ultrapassar esse limite amostral. Assim, a amostra compreendeu 23 insumos diferentes, de um total de 125 descartados pelo Ministério no período analisado. O detalhamento dos insumos analisados na amostra pode ser conferido na tabela a seguir[26].

[24] É a categoria composta pelos demais itens, quando retirados de análise os insumos relacionados à pandemia de Covid-19 e os insumos adquiridos por determinação judicial. Ou seja, são os itens comumente adquiridos pelo Ministério da Saúde.
[25] Dados coletados pela Equipe de Auditoria em visita técnica ao Ministério da Saúde em 20/06/2023.
[26] Tabela ordenada da maior para a menor quantidade de descartes por insumo

Tabela 6 - Percentual de perda de insumos com relação ao quantitativo adquirido, conforme dados de entradas no SISMAT

Insumo descartado	Secretaria	Entradas	Descarte	% Perda
Vacina Dupla Viral (sarampo e rubéola) 10 doses	SVSA	1.670.300	1.015.908	60,82
Vacina Tríplice (DTP) 10 doses	SVSA	4.462.400	866.993	19,43
Vacina contra Febre Amarela - 5 doses	SVSA	14.788.130	578.256	3,91
Vacina Contra Raiva Cultura Celular - 1 dose	SVSA	6.533.000	522.648	8,00
Atazanavir 300 mcg	SVSA	121.913.940	368.670	0,30
Vacina Menigocócica C Conjugada – Frasco	SVSA	29.773.940	344.498	1,16
Vacina Tríplice Viral 5 doses	SVSA	2.040.000	321.284	15,75
Vacina contra Raiva - 1 dose (diluente separado)	SVSA	1.300.000	256.754	19,75
Vacina BCG intradérmico 20 doses	SVSA	2.924.424	252.169	9,62
Vacina pentavalente 1 dose	SVSA	45.766.000	241.778	0,53
Primaquina fosfato 5mg	SVSA	3.210.000	99.100	3,09
Vacina Tríplice Viral (TVV) 10 doses	SVSA	11.118.886	59.481	0,53
Acetato de desmopressina 0,1mg comprimido	SECTICS	2.924.970	2.745.600	93,87
Acetato de desmopressina 0,2mg	SECTICS	1.462.410	1.444.650	98,79
Insulina análoga de ação rápida 100UI/ml inj. 3ml	SECTICS	6.667.163	885.885	13,29
Biotina 2,5mg cápsula	SECTICS	706.260	303.690	43,00
Fosfato de oseltamivir 45mg – cápsula	SECTICS	7.593.000	244.000	3,21
RHZ*	SECTICS	120.816.236	208.218	0,17
Pirazinamida 500mg	SECTICS	4.779.750	181.750	3,80
Etionamida 250mg comp.	SECTICS	618.000	96.000	15,53
Ranitidina clodidrato 150mg comprimido	SESAI	1.500.000	397.800	26,52
Acetado de medroxiplrogesterona 150mg/1ml	SESAI	297.427	11.622	3,91
Desmopressina 15mcg/ml	SAES	2.000	790	39,50
Total geral		392.868.236	11.447.544	2,91

* Rifampicina 150mg + Isoniazida 75mg + Pirazinamida 400mg + cloriddrato de etambutol 275mg
Fonte: Elaboração própria a partir do cotejamento entre dados de descarte em Planilhas entregues à CGU em atendimento às Solicitações de Auditoria nº 03 e nº 12, e dados de entrada no SISMAT, coletados pela Equipe de Auditoria em visita técnica ao Ministério da Saúde em 20.06.2023.

Nos itens geridos pela SVSA, a perda de vacinas se faz notável na análise do percentual de materiais descartados. Dos 23 insumos selecionados na amostra, 10 são vacinas. Ao analisar apenas as vacinas da amostra, chega-se a 3,7% de perda. Destacaram-se as vacinas dupla viral (contra Sarampo e Rubéola) com 60,82% de percentual de perda, tríplice bacteriana (DPT, contra Difteria, Tétano e Coqueluche) com 19,43% e tríplice viral (SCR, contra Sarampo, Caxumba e Rubéola) com 15,75%, por apresentarem alto percentual de perda e quantidade de descartes. Cabe mencionar que todas as vacinas, com exceção das vacinas contra raiva, são do calendário básico de vacinação do PNI, o que, por sua previsibilidade, ofereceria condições para um menor índice de descarte.

Quanto aos itens geridos pela SECTICS, a análise revelou que alguns itens com percentuais menores de perda, mas se comparados com os da SVSA, a tabela mostra o alto percentual de

perda de Acetato de Desmopressina, com taxas de 98,79% e 93,87%, para suas duas apresentações. O medicamento é utilizado para tratamento de diabetes *insipidus*, enurese noturna e distúrbios hemorrágicos.

Os percentuais de perda dos insumos adquiridos pela SESAI (22,78%) e SAES (39,50%) observados na amostra são elevados, quando considerados isoladamente. Porém, quando são considerados em relação ao total da amostra, verifica-se que o quantitativo de perda responde a frações menores, sendo 3,58% (SESAI) e 0,007% (SAES). Isso decorre da menor quantidade de insumos geridos por essas secretarias. Por outro lado, a SVSA e a SECTICS, secretarias que foram responsáveis pela solicitação de compra de mais de 96% dos insumos, apresentaram percentual de perdas de 2,01% e 4,17%, respectivamente.

Na amostra analisada, o Ministério como um todo apresentou um percentual de perda de 2,91% dos insumos que adquire, o que equivale a R$ 159.397.087,96 em valor de insumos. Caso o critério de perdas adotado pelo MS fosse de 1%, por exemplo, seria possível estimar que houve uma perda excedente de 1,91%, e calcular o impacto financeiro correspondente de R$ 54,84 milhões, no período analisado de 2021 a 2023.

Ressalta-se também as vantagens que decorreriam da definição de percentual de perda aceitável insumo (ou ao menos por grupo de insumo) e levando em consideração as particularidades de cada produto. Como observado na amostra, alguns insumos apresentaram proporção de perda muito elevada, enquanto outros insumos ficariam dentro do critério de 1%, o que reforça a necessidade de que cada IES ou tipo de IES possua o seu próprio percentual de perda aceitável devidamente definido.

Uma das causas que foram levantadas junto aos gestores quanto à inexistência dos parâmetros definidos especificamente sobre a perda de vacinas (por ser o grupo de maior materialidade e previsibilidade), é a falta de integração e interoperabilidade dos sistemas informatizados, o que impossibilita o controle e monitoramento da utilização dos insumos em todas as esferas da rede de frio. A disponibilidade de dados é essencial para que as análises possam ser realizadas e os parâmetros adequados estabelecidos para a realidade brasileira (Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente).

Há outros fatores que, embora não tenham sido escopo deste trabalho, poderiam prejudicar as campanhas de vacinação em massa e a confiança nas vacinas em países com esses problemas[27]. No Brasil esses fatores estiveram presentes, provocando impactos preocupantes. De 2001 a 2015, a média nacional de cobertura vacinal se manteve sempre acima dos 70%, mas, em 2016, diminuiu para 59,9% e caiu desde 2019, atingindo os 52,1% em 2021[28]. Esse ambiente diminui a previsibilidade do consumo e consequentemente aumenta o risco de perdas de vacinas e insumos associados.

[27] https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31558-0/fulltext

[28] https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2023-08/brasil-atingiu-em-2021-menor-cobertura-vacinal-em-20-anos#:~:text=De%20acordo%20com%20o%20observat%C3%B3rio,52%2C1%25%20em%202021.

Dados mais recentes indicam reversão dessa tendência:[29] segundo balanço apresentado pelo Ministério da Saúde em dezembro de 2023, das oito vacinas recomendadas para bebês com até 1 ano de idade, sete apresentaram aumento das suas coberturas vacinais em 2023 e os estados apresentaram aumento de cobertura para a vacina DTP, poliomielite, tríplice viral, hepatite A meningocócica e da vacina pneumocócica. A melhora dos números foi confirmada pela OMS, que divulgou em julho de 2024 a informação de que o Brasil conseguiu sair da lista dos vinte países com mais crianças não imunizadas no mundo, um ranking em que o país ocupou o sétimo lugar em 2021.

4.1.2. Fragilidades nos controles sobre o montante de perdas físicas e técnicas de insumos de aquisição centralizada, ocorridas nos entes subnacionais.

O monitoramento do estoque de medicamentos armazenados, inclusive após a distribuição para os entes subnacionais, é uma etapa crucial na gestão da cadeia logística de medicamentos de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde. O monitoramento pós-distribuição não visa apenas garantir a disponibilidade adequada de medicamentos, mas também contribui para a prevenção de perdas e para a programação de futuras aquisições.

Dada a importância da etapa de monitoramento é que se faz necessário pontuar a seguir alguns dos desafios para o aperfeiçoamento do processo.

a) **Consistência dos dados da BNAFAR.** A Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica no SUS, em seu conjunto de dados de saída, prevê os tipos de movimentação "Saída por perda" e "Saída por Validade Vencida". Porém recentemente o Ministério da Saúde verificou fragilidades na arquitetura e em scripts, indicando a necessidade de correção e aperfeiçoamento de maneira que a fidedignidade e representatividade dos dados seja assegurada, conforme prevê a Portaria de consolidação nº 01/2017 – Artigo 395.

b) **Integração dos dados de imunobiológicos na BNAFAR.** Atualmente não há sistema informatizado integrado que possibilite o monitoramento da utilização (ou descarte) dos insumos em todos os pontos da rede de vacinação. O Ministério da Saúde informa que tem realizado discussões internas e externas na tentativa de viabilizar um sistema de informação que forneça dados sobre a posição de estoque de vacinas (incluindo perdas) nos estados e municípios.

c) **Integração dos dados de estoque de insumos adquiridos de forma centralizada entregues diretamente nos entes subnacionais.** A Portaria GM/MS nº 4.777, estabelece em seu artigo 18 que todo bem recebido na forma do caput será, obrigatoriamente, incluído no patrimônio e no sistema informatizado de controle de estoque do Ministério da Saúde. Atualmente a ferramenta utilizada para esse fim é o Sistema Integrado de Administração de Material (SISMAT). Contudo, apurou-se que o

[29] https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/dezembro/brasil-reverte-tendencia-de-queda-nas-coberturas-vacinais-e-oito-imunizantes-do-calendario-infantil-registram-alta-em-2023

SISMAT é utilizado somente para compras com entrega centralizada e, com isso, a Coordenação-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para Saúde - CGLOG/DLOG possui controle apenas do que é entregue no almoxarifado do MS, localizado em Guarulhos/SP. O controle das entregas descentralizadas não é realizado pelo SISMAT, mas pelas áreas requisitantes em articulação com os entes subnacionais. Em outros termos, o controle dos IES dos contratos que possuem previsão de entrega nos almoxarifados estaduais é de competência das equipes de fiscalização das secretarias demandantes/finalísticas deste MS. O SISMAT tem sido objeto recorrente de apontamentos pelos órgãos de controle30 por apresentar limitações para a construção dos balanços patrimoniais do Ministério da Saúde, para o planejamento logístico e controle dos estoques. O monitoramento das recomendações realizado ao longo de 2023 e 2024 indica que o Ministério da Saúde está em fase de implementação do plano de ação para a migração para o SIADS, que é um sistema considerado mais apto para a gestão desse tipo de informação. Até que a migração esteja concluída, continuará sendo um fator de risco quanto aos controles de estoques de insumos estratégicos.

4.1.3. Inadequações do Sistema SISMAT, registradas em relatórios anteriores da CGU e do TCU, com recomendação de substituição do sistema.

Para que a gestão de insumos estratégicos funcione conforme previsto nos normativos que regulamentam o tema (Portaria GM/MS nº 4.777/2022), faz-se necessário que os sistemas informatizados do Ministério da Saúde estejam adequados às necessidades previstas no ato normativo e possibilitem o controle dos insumos, de forma eficiente, fidedigna e tempestiva.

As melhores práticas de gestão de insumos requerem informação gerencial em tempo real a respeito dos estoques. O volume de recursos, a multiplicidade de atores e a quantidade e variedade de insumos manipulados pelo Ministério da Saúde no Macroprocesso Gestão de IES exigem a adoção de sistema de informação que permita a integração com a cadeia logística e a emissão de relatórios gerenciais que tragam informações oportunas, completas e corretas, visando a tomada de decisão.

Nesse cenário, ganha destaque o Sistema Integrado de Administração de Material (SISMAT), utilizado pelo Ministério da Saúde para registrar as entradas e saídas de materiais (incluídos os IES), controlar os níveis de estoque e auxiliar no planejamento de reposição. O referido Sistema, entretanto, tem sido alvo recorrente de críticas e recomendações em trabalhos de auditoria, elencados no quadro a seguir:

[30] Apontamentos feitos pela CGU nas Auditorias Anuais de Contas de 2021 e 2022 e pelo TCU no Acórdão nº 313/2023

Quadro 1 – Achados relativos ao SISMAT de trabalhos anteriores de órgãos de controle

Documento	Achado	Recomendações / Determinações	Implementação / Encaminhamento
Relatório de Avaliação CGU 1016345 – Auditoria Anual de Contas 2021	2.1.1 - Registro contábil intempestivo de saídas da conta de estoques de medicamentos/insumos estratégicos (2021), superavaliando o ativo em R$ 6 bilhões	Implementar plano de ação para substituição do SISMAT pelo Siads como sistema de controle patrimonial dos estoques de medicamentos/insumos estratégicos	Auditoria de Contas de 2022 apontou que "Ministério da Saúde apresentou melhorias em áreas como Estoques, uma vez que não se repetiu a distorção provocada pelo registro contábil intempestivo de saídas da conta de estoques de medicamentos / insumos estratégicos."
	2.1.9 - Reconhecimento contábil (2021) de saídas de medicamentos dos almoxarifados ocorridas em exercício anterior, subavaliando o resultado do exercício em R$ 1 bilhão	Implementar plano de ação para substituição do SISMAT pelo Siads como sistema de controle patrimonial dos estoques de medicamentos/insumos estratégicos	Auditoria de Contas de 2022 apontou que a recomendação está pendente de atendimento.
	2.4.8 - Intempestividade e elevado índice de erro nos registros dos medicamentos/insumos estratégicos	Implementar plano de ação para substituição do SISMAT pelo Siads como sistema de controle patrimonial dos estoques de medicamentos/insumos estratégicos	Auditoria de Contas de 2022 manteve a necessidade de monitoramento da recomendação, que foi reformulada visando implantação do SIADS.
Relatório de Avaliação CGU 1287104 – Auditoria Anual de Contas 2022	Falhas nos controles de estoque de insumos estratégicos em saúde em relação aos saldos dos sistemas utilizados e à contagem física realizada no almoxarifado de Guarulhos/SP.	Aprimorar o controle dos insumos estratégicos de forma que os sistemas informatizados, tanto o utilizado pelo Ministério da Saúde quanto o da operadora de logística, reflitam adequadamente os estoques existentes.	Até o momento deste relatório, encontra-se pendente de implementação.
Acórdão nº 313/2023 – TCU	Deficiências no planejamento logístico	9.4. determinar ao Ministério da Saúde (...) que apresente plano de ação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, identificando as ações a serem adotadas, os responsáveis por cada uma delas e prazos para a implementação, com vistas à substituição do SISMAT (...)	Até a emissão deste relatório, encontra-se pendente de implementação.
	Fragilidades nos controles internos		

Fonte: Elaboração própria a partir dos Relatórios citados.

Como pode ser observado, tanto os trabalhos da Controladoria-Geral da União quanto o do Tribunal de Contas da União apontam como uma das soluções aos problemas de gestão de IES a substituição do SISMAT, indicando que o sistema utilizado atualmente fragiliza os processos

de elaboração dos balanços patrimoniais do Ministério da Saúde, de planejamento logístico e de controle dos estoques.

Ainda quanto às limitações do sistema, em visita técnica da Equipe de Auditoria ao Ministério da Saúde para coleta de dados, constatou-se que o SISMAT não possui funcionalidades importantes para a gestão dos insumos estratégicos, como extração automatizada de relatórios gerenciais (giro de estoque, custo médio de estoque, rotatividade, dentre outros) e emissão de planilhas eletrônicas (em Excel ou OpenOffice). Para fins de controle de estoque e inventário, o sistema apenas emite relatórios em formato PDF, o que representa um grande fator limitante da capacidade de gerenciar os estoques de insumos.

Quanto à substituição do SISMAT pelo SIADS, o Ministério relatou desafios sistêmicos significativos, dentre os quais, a interlocução com o órgão gerenciador (STN). Ainda, não há informações quanto à data em que será concluída a transição ou quanto à etapa em que se encontra o processo em relação ao Plano de Ação[31].

Quanto a esse ponto, cabe destacar que nesta auditoria não foram realizados novos testes, uma vez que a matéria já foi devidamente examinada pelos órgãos de controle e já possui recomendações e determinações em andamento. O tema foi trazido a este relatório por ser um fator relevante relacionado à ocorrência de perdas de insumos estratégicos em saúde.

4.1.4. Descumprimento da Portaria GM/MS nº 4.777/2022, referente às ações para prevenção de perda de Insumos Estratégicos em Saúde.

No âmbito do Ministério da Saúde, os procedimentos de planejamento, aquisição e gestão de insumos estratégicos em saúde são regulados pela Portaria GM/MS nº 4.777/2022. O Capítulo, III Seção I estabelece que as áreas requisitantes devem monitorar a quantidade de insumos armazenados e acompanhar a evolução da demanda por meio de sistema informatizado do Ministério da Saúde.

Na Portaria são delimitadas as ações para prevenção de perdas. Conforme Artigo 23, o DLOG/MS deve emitir, mensalmente, comunicado aos setores requisitantes a respeito dos insumos obtidos e que estejam estocados no Centro de Distribuição do órgão em situação de: *I - iminência de perda por decurso de validade;* ou *II - estocados em situação de aparente perda ou avaria.*

Na sequência, o Artigo 24 determina que recebido o comunicado, o requisitante deve se manifestar no prazo de 14 dias, informando, para cada insumo estratégico: I - a expectativa de utilização; II - as providências tomadas para evitar a perda; III - a confirmação ou não da situação de perda ou avaria; e IV - a autorização expressa para descarte ou a justificativa para a manutenção em estoque por prazo alongado, em caso de perda confirmada.

[31] Nota Técnica nº 14/2021 – SPO/CCONT/CGORF/SPO/SE/MS.

Nos casos em que haja expectativa de utilização, existem ações preventivas a serem adotadas em tempo hábil para que o insumo possa ser utilizado sem perda de validade, tais como: supressão unilateral nas compras, cancelando as entregas que ainda não tiverem sido feitas, substituição do medicamento com validade próxima a expirar (carta de troca), proposição de mudança da forma de utilização do insumo em risco, extensão da validade, utilização para outros fins não previstos inicialmente (ex. pesquisas científicas), doação do insumo estratégico próximo ao vencimento.

Com objetivo de verificar o cumprimento dos dispositivos constantes na Portaria GM/MS nº 4.777/2022, foram analisados 122 lotes de insumos que adentraram o período crítico para perda iminente (240 dias para o fim da validade) e posteriormente foram descartados pelo Ministério da Saúde durante a vigência da referida portaria (2023). Os resultados estão foram os registrados a seguir:

Houve comunicação do DLOG à área requisitante quanto à iminência de perda por decurso de validade para os 122 lotes analisados. Em 53 casos houve manifestação da Secretaria Requisitante dentro do prazo, em conformidade com o procedimento. Em 69 casos não houve manifestação, ou a manifestação foi incompleta, ou se deu fora do prazo estipulado. Desses 69 casos não aderentes ao procedimento, as ocorrências foram classificadas nas seguintes situações: em 14 deles as secretarias não se manifestaram, em 10 deles houve a manifestação de pelo menos uma das secretarias requisitantes (mas não todas) e em 45 casos consta a manifestação das secretarias requisitantes, porém em prazo superior aos 14 dias estabelecidos na norma, variando entre 17 e 88 dias após a comunicação inicial do DLOG.

A manifestação, como exigida na Portaria, abordaria a expectativa de utilização dos insumos com iminência de perda; as providências tomadas para evitar a perda; a confirmação da situação de perda ou avaria e autorização expressa para descarte ou justificativa para a manutenção em estoque por prazo alongado, em caso de perda confirmada.

No entanto, constatou-se que, mesmo nos processos em que houve a manifestação no prazo estipulado pela Portaria, as informações apresentadas limitaram-se a afirmativas de que havia previsão de consumo dos medicamentos antes do prazo de validade, sem fornecer detalhes sobre as medidas adotadas para prevenir perdas. Cabe mencionar que uma parte dos insumos citados no despacho acabou sendo perdida e descartada para incineração.

Constatou-se ainda que em todos os 122 lotes analisados na amostra não constava no processo a autorização expressa para o descarte, conforme determina a portaria. Esse dispositivo da norma tem a finalidade de evitar despesas indevidas de armazenagem, pois tão logo o gestor perceba que não será possível evitar a perda, deve manifestar-se autorizando o descarte.

O dispositivo que prevê que o DLOG acione a Secretaria Executiva do Ministério quando a área requisitante não responde no prazo previsto também não está sendo plenamente utilizado, posto que, dos 69 casos da amostra em que não houve manifestação da Secretaria Requisitante ou a mesma não ocorreu dentro do prazo estipulado, em apenas seis o DLOG

acionou a Secretaria Executiva e, mesmo nesses casos, não houve ação por parte da Secretaria Executiva no sentido de instar o requisitante a se manifestar.

4.1.5 Inadequações em termos e dispositivos da PORTARIA GM/MS nº 4.777/2022, que regula os procedimentos de planejamento, aquisição e gestão de IES.

Na seção II do capítulo dedicado na Portaria GM/MS nº 4.777/2022 à gestão de insumos estratégicos em saúde são delimitadas as ações para prevenção de perdas.

Para que se minimizem os riscos de perda de insumos estratégicos em saúde por motivos de decurso de prazo de validade ou avarias durante o processo de armazenamento, faz-se necessário que a norma regulamentadora da matéria, no caso concreto a citada portaria, contemple, de forma objetiva, procedimentos de controle adequados às necessidades e à realidade da gestão desses insumos estratégicos e que sejam suficientes para evitar desperdícios de recursos públicos e outras impropriedades ou irregularidades decorrentes de falhas na gestão desses insumos.

Na análise do conteúdo da Portaria GM/MS n° 4.777, de 30.12.2022, foram identificadas inadequações de dispositivos e de termos passíveis de ajustes ou que necessitam ser complementadas com informações que possibilitem a sua melhor compreensão, conforme segue:

a) Artigo 22: Falha na definição de termos do Artigo 22

O Artigo 22 define que "compete aos requisitantes monitorar, periodicamente, a quantidade de insumos estratégicos em saúde armazenados e acompanhar a evolução da demanda, por meio de sistema informatizado do Ministério da Saúde." A portaria não esclarece se o monitoramento periódico diz respeito apenas aos insumos "armazenados" no Centro de Distribuição ou se inclui os IES de aquisição centralizada armazenados nos entes subnacionais.

Adicionalmente, a portaria também não define em que consiste o termo "evolução da demanda", se o monitoramento incluiria a distribuição, o consumo nos estoques subnacionais ou até a destinação ao descarte na pós-distribuição do Ministério da Saúde.

b) Artigo 22: Ausência de hierarquização das medidas para prevenção de perdas de IES

O artigo 22 trata também da gestão dos insumos estratégicos em saúde em estoque com data para expirar inferior a 240 dias e relaciona seis ações preventivas a serem adotadas em tempo hábil para que o insumo possa ser utilizado sem perda de validade (I – supressão de compras; II – carta de troca; III - alteração da forma de utilização do insumo; IV - extensão da validade do insumo; V - utilização para outros fins não previstos inicialmente, como pesquisas científicas; VI - doar o insumo para utilização no País, fora do SUS ou por cooperações de ajuda internacional). Essas ações estão dispostas em caráter exemplificativo às providências, no sentido de alternativas válidas em um contexto de possibilidades de atos de gestão.

Entende-se que devam ser priorizadas as medidas que evitam o dano e definidos tempos máximos para execução de cada uma delas, em detrimento das ações que minimizam o dano já ocorrido.

Quanto aos incisos V e VI, é importante ressaltar que a utilização dos IES em fins divergentes dos inicialmente previstos deve ser o último recurso. Vale dizer, os incisos V e VI só deveriam ser acionados apenas quando todas as etapas anteriores não tivessem logrado êxito, mas que tivessem sido cumpridas e devidamente registradas nos processos administrativos correlatos.

Além disso, ressalte-se que os incisos de III a VI podem resultar em informação gerencial equivocada de que tais insumos foram devidamente destinados ao consumo entrando novamente na programação de compras dos anos subsequentes.

c) Artigo 23: Ausência de definição do conceito utilizado no inciso I "iminência de perda por decurso de validade"

O artigo 23 determina que o DLOG emita, mensalmente, comunicado aos setores requisitantes a respeito dos insumos estratégicos em saúde que estejam estocados no Centro de Distribuição do órgão em situação de "iminência de perda por decurso de validade". Não é objetivamente claro se o termo "iminência de perda por decurso de validade" está condicionado aos 240 dias mencionados no Artigo 22, ou se representa um estágio posterior no vencimento do insumo.

d) Artigo 28: Indefinição quanto ao encaminhamento a ser dado quanto à possível apuração de responsabilidade, tendo em vista a extinção da Diretoria de Integridade (DINTEG):

O Artigo 28 do normativo define que: “Os casos que ensejarem perda de insumo estratégico serão enviados à Diretoria de Integridade, dando-se ciência à Secretaria-Executiva, para avaliação quanto a possível apuração de responsabilidade.” Como se observa, a Diretoria de Integridade (DINTEG) foi inserida no texto da portaria como órgão que atuaria no controle, avaliando se as perdas de IES detectadas seriam passíveis de apuração de responsabilidade.

No entanto, dois dias após a publicação da Portaria GM/MS nº 4.777/2022, o Decreto nº 11.358/2023, o qual aprova a Estrutura Regimental do Ministério da Saúde, extinguiu a citada DINTEG, distribuindo parte de suas atribuições à Assessoria Especial de Controle Interno (AECI). Contudo, a AECI não herdou atribuição imposta à DINTEG disposta eu outro normativo, qual seja, o Decreto 11.098/2022, qual seja: “analisar e apurar fatos, denúncias e representações sobre fraude e corrupção praticados contra a administração pública por agentes públicos ou privados no âmbito do Ministério” (Art. 8º, VIII).

Portanto, conclui-se pela ausência de normatização adequada de aspectos relevantes na Portaria GM/MS nº 4.777/2022, que regula os procedimentos de planejamento, aquisição e gestão de insumos estratégicos em saúde.

4.2. Fatores relacionados à logística

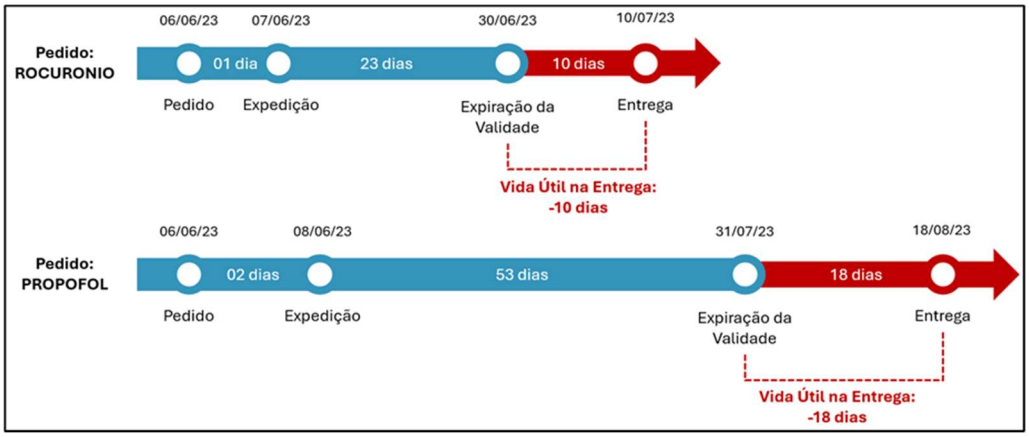
4.2.1. Tempo de Transporte do Operador Logístico

Outro fator que que pode impactar a eficiência do macroprocesso analisado é o tempo de transporte do operador logístico, considerado neste relatório como sendo a contagem em dias entre a data de expedição e a data de sua entrega no município solicitante.

Dados de saída de insumos entre 2021 e 2023, extraídos do Portal do Operador Logístico, demonstraram que o tempo de transporte de insumos (entre expedição e entrega) ocorreu em até 71 dias evidenciando inclusive, insumos que expiraram durante o tempo de transporte.

A título de exemplo, a figura abaixo ilustra um caso concreto. Trata-se do pedido de anestésicos (Rocurônio e Propofol), feito pela Santa Casa de um município do estado de São Paulo localizado a menos de 100km do depósito central em Guarulhos.

Figura 1 - Linha do tempo logístico entre o Pedido e a Entrega dos insumos Rocurônio e Propofol destinados à Santa Casa de um município no interior de São Paulo



Fonte: Elaboração própria a partir de Planilha extraída do Portal do Operador Logístico, encaminhada à CGU em atendimento à solicitação durante Visita Técnica à VTCLOG.

Desse caso específico, quatro fatos se destacam: o primeiro é que os dois anestésicos saíram do Centro de Distribuição com poucos dias de vida útil restantes (23 e 53 dias, respectivamente); o segundo é que ambos tiveram suas validades expiradas ainda no período de transporte; o terceiro é que o tempo de entrega desses insumos foi bastante distinto, (34 e 73 dias, respectivamente) mesmo em condições logísticas favoráveis (dentro do mesmo estado, pouca distância e boas estradas); por fim, o quarto ponto é que essas informações foram extraídas do Portal do Operador Logístico e não constam nos dados de saída fornecidos pelo Departamento de Logística do Ministério, uma vez que estes não especificam a data de entrega, fornecendo apenas a data de expedição dos insumos.

4.2.2. Recebimento de insumos, no Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, com validade inferior a 70% do seu prazo de vida útil.

Em função da complexidade da cadeia logística, é necessário que os produtos adquiridos tenham prazo de validade compatível com o tempo necessário para garantir que as etapas de armazenamento, distribuição e disponibilidade ao usuário final sejam realizadas com segurança.

Em que pese a ausência de previsão normativa na Portaria GM/MS nº 4.777/2022, quanto à validade mínima para recebimento de insumos, verificou-se como boa prática o Modelo de Termo de Referência da Advocacia Geral da União para aquisições, que traz cláusula determinando que o comprador deve exigir prazo de validade mínimo no caso de produtos perecíveis como medicamentos e insumos para a saúde:

> "No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a ..... (.....) (dias ou meses ou anos), ou a (metade, um terço, dois terços etc.) do prazo total recomendado pelo fabricante."

Exames adicionais indicaram que o DLOG busca seguir essa boa prática, o que se verifica em sua manifestação sobre o tema:

> [...] nos Termos de Referência - TRs, a contratada deverá entregar o objeto devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, com prazo de validade, sendo que, entre a data de fabricação e a data da entrega, não deverá ter transcorrido mais de 30% do prazo de validade. O não cumprimento do prazo de validade apontado poderá caracterizar descumprimento parcial do contrato e a contratada poderá sofrer sanção.
>
> Na hipótese do não cumprimento do limite preconizado anteriormente, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, a contratante deverá ser consultada oficialmente. No caso de aceitação, pela área responsável pelo insumo, da carta de comprometimento de troca, o fornecedor deverá realizar a troca do quantitativo que expirou o prazo de validade, podendo ocorrer nos estados da federação ou no armazém do MS. O fornecedor deverá se comprometer a retirar o objeto contratado vencido para o devido descarte, sem ônus à contratante, isto é, este Ministério.

Com o objetivo verificar o fato, foram analisados 30 Termos de Referência de licitações homologadas pelo Ministério da Saúde em 2022, extraídos do portal de compras do Governo Federal[32]. A análise confirmou que a cláusula modelo da AGU indicando prazo de validade mínima se fazia presente em todos os casos com a seguinte redação: "No ato da entrega, não deverá ter transcorrido mais de 30% (trinta por cento) do prazo de validade do medicamento, conforme seu registro na Anvisa".

No que tange ao processo de recebimento de insumos, o Ministério da Saúde não informou quais os procedimentos adotados para cumprimento da cláusula contratual que prevê validade mínima no momento do recebimento dos IES. Segundo apurado, a conformidade

[32] http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp

quanto à validade mínima ocorre no momento do recebimento dos insumos no centro de distribuição, com base na documentação apresentada pelo fornecedor.

A verificação caso a caso é uma forma de controle possível, porém requer a designação de pessoas em número suficiente para garantir a integridade da operação. Ocorre que, em visita técnica ao Centro de Distribuição do Operador Logístico (VTCLOG), constatou-se a ausência de servidores designados pelo Ministério da Saúde na execução da etapa de recebimento.

O recebimento de insumos adquiridos pelo Ministério da Saúde é executado pelo Operador Logístico contratado, mediante preenchimento do documento "Checklist de Recebimento", no qual consta a inspeção da data de validade com o critério "superior ou inferior a 1 ano de validade". Contudo, a conferência de validade superior a 1 ano não atende à cláusula contratual que prevê validade mínima (até 30% do prazo de validade transcorrido) no momento do recebimento dos IES.

Com o intuito de avaliar a adequabilidade da gestão no que se refere às ações de prevenção de perdas, foram feitos testes de conformidade segundo critérios objetivos que incidem sobre a etapa de recebimento dos insumos. Partindo-se do total de insumos encaminhados para descarte no Centro de Distribuição do Ministério da Saúde no período de 2021 a 2023 por perda do prazo de validade, foi feito um recorte para se obter aqueles com menos de 511 dias de vida útil[33]. Em seguida, foram excluídos os insumos relacionados à pandemia de Covid-19, e os insumos decorrentes de demandas judiciais, por estarem sujeitos a demandas e fluxos extraordinários. Assim, os exames se concentraram sobre o grupo cuja gestão pode ser considerada mais típica e, portanto, mais aderente às regras e procedimentos estabelecidos para minimizar perdas.

Feitas essas delimitações, foram selecionados, por meio de amostra não probabilística, 55 lotes de insumos, que foram submetidos aos exames descritos a seguir.

O primeiro exame testou a relação entre a data de fabricação e a data de recebimento do insumo, sendo considerados adequados os lotes recebidos com mais de 70% de sua vida útil remanescente. Como resultado, constatou-se que, dos 55 lotes da amostra, 29 estavam adequados por atenderem ao critério e 26 foram considerados inadequados.

O segundo exame foi aplicado aos 26 lotes recebidos com vida útil menor que 70%, a fim de averiguar a existência de documento referente à manifestação técnica da secretaria requisitante acerca da viabilidade ou não do recebimento dos insumos entregues com mais de 30% de sua vida útil transcorrida. Como resultado, constatou-se que em 24 dos 26 lotes examinados, não havia manifestação da área técnica autorizando o recebimento dos insumos, sendo, portanto, considerados em desconformidade quanto a esse teste.

O terceiro exame foi aplicado aos mesmos 26 lotes recebidos com vida útil menor que 70%, visto que a autorização para recebimento não afasta a responsabilidade do fornecedor de

[33] Os 511 dias correspondem a 70% de 650 dias (considerando que a vida útil para a maioria dos insumos é de 2 anos)

garantir a troca, por se tratar de cláusula contratual. Assim, o teste buscou verificar se havia carta de troca no processo e se houve troca efetiva dos insumos relacionados aos lotes analisados. Como resultado, constatou-se que em 14 lotes não havia carta de troca ou outro documento do fornecedor que embasasse a substituição de insumos por perda de prazo de validade. Em 12 lotes, havia cartas de troca, contudo não constam nos processos informações suficientes para comprovar que os insumos foram realmente trocados por outros com validade igual ou superior que 70% do tempo de vida útil.

Recapitulando, este tópico do relatório buscou averiguar o recebimento de insumos com vida útil inferior a 70% como um fator que amplia o risco de perdas. Para isso, foi percorrido o caminho inverso: partindo de uma relação de insumos enviados para descarte, aplicaram-se os testes já descritos acima, que permitiram sumarizar algumas observações.

A primeira observação é que 29 dos 55 casos de perdas analisadas (52,7%), foram recebidos com mais de 70% de vida útil, o que indica a necessidade de que os procedimentos logísticos sejam aperfeiçoados, considerando que a elevação do parâmetro para mais de 70% da validade pode ser inviável do ponto de vista dos fornecedores.

A segunda observação é que 26 dos 55 casos de perdas analisadas (47,3%), foram recebidos com menos de 70% de vida útil, mas que não seguiram os procedimentos existentes para mitigação do risco de perdas, uma vez que em 14 processos não havia carta de troca e, nos 12 processos em que a carta estava presente, não havia evidências de que a troca foi realizada.

Esses achados indicam a necessidade de aperfeiçoamento dos fluxos e procedimentos, bem como dos mecanismos de controle a eles associados, uma vez que os processos analisados apresentaram desconformidade com regras já estabelecidas e a ausência de medidas que poderiam ter minimizado as perdas.

4.2.3. Ausência de critérios mínimos para recebimento de doações, tendo havido perdas de IES doados por decurso do prazo de validade.

Neste item do relatório contempla-se a avaliação da gestão no que se refere ao recebimento de doações de insumos estratégicos em saúde e as causas de eventuais perdas por vencimento do prazo de validade. A matéria é normatizada no artigo 9º da Portaria GM/MS nº 4.777/2022:

> § 2º O dirigente da área requisitante é responsável pelo aceite das doações, devendo justificar, nos processos, as quantidades aceitas, para evitar perdas decorrentes de não utilização, expiração da validade e despesas com transporte e armazenagem dos insumos estratégicos em saúde recebidos, nos termos do Decreto nº 9.764, de 11 de abril de 2019 e respectiva regulamentação.

Do levantamento feito junto às áreas finalísticas do Ministério da Saúde, foi possível constatar que a SECTICS estabelece critérios mínimos para o recebimento de doações ao definir que em seus termos de referência conste a exigência de que não poderá ter transcorrido mais de 30% (trinta por cento) do prazo de validade do medicamento, contado da data de fabricação até a data de emissão da fatura. Por exemplo, se um medicamento tem validade total de 10 meses,

ele deve ser aceito somente se ainda houver pelo menos 7 meses até seu vencimento. Não foram identificadas regras semelhantes estabelecidas pelas demais áreas sobre a adoção de critérios mínimos para o recebimento de doações, tais como previsão de utilização dos insumos, prazos mínimos de validade ou motivação pelo recebimento das doações.

Do total de insumos encaminhados para descarte, foi possível verificar que 2,3% desse volume foi recebido por doação, que, em valores monetários, correspondem a R$40,9 milhões. Excluindo-se os insumos relacionados à Pandemia de Covid-19, por estarem submetidos a condições atípicas inerentes à situação de crise, chega-se ao subconjunto composto por 16 lotes, que correspondem a R$2,5 milhões, conforme detalhamento na tabela abaixo.

Tabela 7 - Insumos descartados recebidos por meio de doações, excluídos os insumos relacionados à Pandemia de Covid-19

Insumo descartado	Lote	Secretaria	Quantidade	Valor (R$)
Vacina contra gripe 10 doses	200132	SVSA	9.622	1.443.300,00
Vacina contra gripe 10 doses	200131	SVSA	6.806	1.020.900,00
Sofosbuvir 400mg comp.	207000593	SVSA	2.520	81.512,78
Kit diagnóstico Filariose 30 testes	133909	SECTICS	50	16.333,99
Anfotericina B 5mg/ml inj.20ml	8331B	SECTICS	15	7.628,85
Dietilcarbamazina 50mg	18030052	SECTICS	225.500	3.213,39
Nifurtimox 120mg	SVF2535	SECTICS	5.700	706,76
Artesunato+Cloridr. Mefloquina 25+55mg 6 comp	19111150*	SVSA	740	646,46
Kit de infusão emicizumabe (Hemcibra)*	11000	DJUD	52	568,36
Kit para infusão (Remipack) infliximabe	11989	CGJUD	15	525,30
Artesunato+Cloridr.Mefloquina 25+55mg 3 comp	20050595*	SVSA	770	339,37
Rifampicina 150+300mg Dapsona 50mg	KG1809	SECTICS	48	222,44
Poliquimioterapia única pqt u adulto	KU2990	SECTICS	12	181,19
Kit de infusão emicizumabe (Hemcibra)*	21000	DJUD	15	163,95
Medidor de monitoramento de glicose (monitor)*	12360407	DJUD	10	32,15
Dietilcarbamazina 50mg	19090775	SECTICS	500	7,13
Total	**-**	**-**	**252.375**	**2.576.279,12**

Fonte: Elaboração própria a partir de informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde
* Processos não disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

A fim de conhecer o perfil dos itens que compõem esse grupo, foram feitas análises sobre 11 dos 16 lotes. Dessas análises, cabe mencionar alguns exemplos, por trazerem situações que podem suscitar reflexões sobre melhorias nas regras e procedimentos relativos ao recebimento de doações.

a) **Processo de doação do insumo Nifurtimox 120 mg**: consta a informação que estava em desenvolvimento um novo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Doença de Chagas, o qual traria a recomendação de uso do Nifurtimox como 2ª linha de tratamento e, com esse novo protocolo, poderia ocorrer um aumento no consumo. Assim, a demanda estimada informada à OPAS para a doação do ano de 2018 foi de 20.000 comprimidos. Conforme apresentado na Tabela 9 (acima), dos 20.000 comprimidos estimados para o uso, 5.700 não foram utilizados, sendo descartados ainda no Centro de Distribuição. Por se tratar de um protocolo ainda novo, é razoável supor que haja perdas, considerando que o ajuste entre demanda e o estoque seja ajustado com o tempo. Contudo, no processo que trata do caso não há informações

mais detalhadas sobre a origem da demanda, como por exemplo o comportamento da doença no Brasil, a taxa de falha do tratamento de primeira linha e a necessidade de alternativas terapêuticas, o plano de distribuição e relatórios sobre o consumo efetivo para subsidiar ajustes no protocolo ou decisões futuras sobre a sua continuidade do protocolo.

b) Processo de doação de comprimidos de Sofosbuvir 400mg: doação de 3.988 comprimidos feita em troca de 20.000 comprimidos vencidos em estoque no Centro de Distribuição do Ministério da Saúde. As análises permitiram verificar que, apesar de constar como troca, o que ocorreu, de fato, foi o descarte dos 20.000 comprimidos e o recebimento de mais 3.988 comprimidos que entraram no estoque. Contudo, a quantidade recebida em doação já chegou com 87% de sua vida útil já transcorrida, e foi posteriormente descartada em quase sua totalidade, pois constatou-se que, entre os descartes de insumos no período de 2021 a 2023, constam unidades de Sofosbuvir 400mg que incluem as quantidades adquiridas e doadas ao Ministério da Saúde.

c) Prazo de validade no momento do recebimento: Dos 11 medicamentos recebidos por doação, 8 tinham prazo de validade inferior aos 70% da vida útil no momento da entrada no estoque. Muito embora a dinâmica das doações tenha peculiaridades inerentes à sua própria natureza, é necessário que haja algum referencial quanto ao prazo de validade quanto aos critérios para o recebimento de insumos estratégicos em saúde, inclusive por doação, considerando o prazo de validade remanescente quando da data de recebimento do insumo, dados os custos logísticos de seu recebimento, armazenamento e descarte.

Se por um lado a amostra examinada não tenha sido selecionada com o intento de proporcionar representatividade estatística aos resultados, por outro, os casos revelados são suficientes para reforçar as evidências quanto à necessidade de aprimoramento nas regras, fluxos e controles internos relativos às doações.

RECOMENDAÇÕES

Recomendação 1 (Achados 2 e 4.1.1) – À SVSA/MS - definir percentuais aceitáveis de perdas para cada Insumo Estratégico em Saúde (IES). Para tanto, elaborar Plano de Ação, contendo minimamente:

- Levantamento dos percentuais de perda para os IES de aquisição centralizada pelo Ministério, com base na série histórica de perdas dos insumos nos últimos 5 anos;
- Definição do percentual aceitável de perdas para as próximas aquisições de IES, preferencialmente para cada insumo ou tipo de insumo, levando em consideração, além da série histórica de perdas, dados epidemiológicos, morbidade e condição de saúde da população.

Recomendação 2 (Achados 2 e 4.1.1) – À SECTICS/MS - definir percentuais aceitáveis de perdas para cada Insumo Estratégico em Saúde (IES). Para tanto, elaborar Plano de Ação, contendo minimamente:

- Levantamento dos percentuais de perda para os IES de aquisição centralizada pelo Ministério, com base na série histórica de perdas dos insumos nos últimos 5 anos;
- Definição do percentual aceitável de perdas para as próximas aquisições de IES, preferencialmente para cada insumo ou tipo de insumo, levando em consideração, além da série histórica de perdas, dados epidemiológicos, morbidade e condição de saúde da população.

Recomendação 3 (Achados 2 e 4.1.1) –À SESAI/MS - definir percentuais aceitáveis de perdas para cada Insumo Estratégico em Saúde (IES). Para tanto, elaborar Plano de Ação, contendo minimamente:

- Levantamento dos percentuais de perda para os IES de aquisição centralizada pelo Ministério, com base na série histórica de perdas dos insumos nos últimos 5 anos;
- Definição do percentual aceitável de perdas para as próximas aquisições de IES, preferencialmente para cada insumo ou tipo de insumo, levando em consideração, além da série histórica de perdas, dados epidemiológicos, morbidade e condição de saúde da população.

Recomendação 4 (Achados 2 e 4.1.1) –À SAES/MS - definir percentuais aceitáveis de perdas para cada Insumo Estratégico em Saúde (IES). Para tanto, elaborar Plano de Ação, contendo minimamente:

- Levantamento dos percentuais de perda para os IES de aquisição centralizada pelo Ministério, com base na série histórica de perdas dos insumos nos últimos 5 anos;

- Definição do percentual aceitável de perdas para as próximas aquisições de IES, preferencialmente para cada insumo ou tipo de insumo, levando em consideração, além da série histórica de perdas, dados epidemiológicos, morbidade e condição de saúde da população.

Recomendação 5 (Achado 3) - À SVSA/MS - elaborar Procedimento obrigatório, que contenha minimamente: a) identificação de situações de perda de insumos (outras, além de descarte por incineração); b) Forma de registro de perdas em sistema ou planilhas de controle; c) Previsão de utilização dos registros de perda para embasar a programação de novas compras.

Recomendação 6 (Achado 3) - À SECTICS/MS - elaborar Procedimento obrigatório, que contenha minimamente: a) identificação de situações de perda de insumos (outras, além de descarte por incineração); b) Forma de registro de perdas em sistema ou planilhas de controle; c) Previsão de utilização dos registros de perda para embasar a programação de novas compras.

Recomendação 7 (Achado 3) - À SESAI/MS - elaborar Procedimento obrigatório, que contenha minimamente: a) identificação de situações de perda de insumos (outras, além de descarte por incineração); b) Forma de registro de perdas em sistema ou planilhas de controle; c) Previsão de utilização dos registros de perda para embasar a programação de novas compras.

Recomendação 8 (Achado 3) - À SAES/MS - elaborar Procedimento obrigatório, que contenha minimamente: a) identificação de situações de perda de insumos (outras, além de descarte por incineração); b) Forma de registro de perdas em sistema ou planilhas de controle; c) Previsão de utilização dos registros de perda para embasar a programação de novas compras.

Recomendação 9 (Achado 3) – À SVSA/MS – implementar, em pactuação com CONASS e CONASEMS, mecanismos de relato de perdas, tais como sistemas de registro online, para comunicação em todas as etapas da cadeia logística de distribuição, incluindo entes subnacionais.

Recomendação 10 (Achado 3) – À SECTICS/MS - implementar, em pactuação com CONASS e CONASEMS, mecanismos de relato de perdas, tais como sistemas de registro online, para comunicação em todas as etapas da cadeia logística de distribuição, incluindo entes subnacionais.

Recomendação 11 (Achado 3) – À SESAI/MS - implementar, em pactuação com CONASS e CONASEMS, mecanismos de relato de perdas, tais como sistemas de registro online, para comunicação em todas as etapas da cadeia logística de distribuição, incluindo entes subnacionais.

Recomendação 12 (Achado 3) – À SAES/MS - implementar, em pactuação com CONASS e CONASEMS, mecanismos de relato de perdas, tais como sistemas de registro online, para comunicação em todas as etapas da cadeia logística de distribuição, incluindo entes subnacionais.

Recomendação 13 (Achado 3) - À SVSA/MS - elaborar estudos específicos por estado da federação, que detalhem o tempo logístico mínimo necessário como critério de validade mínima para distribuição de cada grupo de insumo até a dispensação final ao usuário.

Recomendação 14 (Achado 3) - À SECTICS/MS - elaborar estudos específicos por estado da federação, que detalhem o tempo logístico mínimo necessário como critério de validade mínima para distribuição de cada grupo de insumo até a dispensação final ao usuário.

Recomendação 15 (Achado 3) - À SESAI/MS - elaborar estudos específicos por estado da federação, que detalhem o tempo logístico mínimo necessário como critério de validade mínima para distribuição de cada grupo de insumo até a dispensação final ao usuário.

Recomendação 16 (Achado 3) - À SAES/MS - elaborar estudos específicos por estado da federação, que detalhem o tempo logístico mínimo necessário como critério de validade mínima para distribuição de cada grupo de insumo até a dispensação final ao usuário.

Recomendação 17 (Achados 2 e 4.1.1) – À SE/MS - elaborar norma para institucionalizar o uso do percentual aceitável de perdas, após definição pelas Secretarias Requisitantes de IES (SVSA, SECTICS, SESAI, SAES), no Ministério da Saúde, em especial, no planejamento, programação, compras e monitoramento das futuras aquisições de IES.

Recomendação 18 (Achado 4.1.2) - À SE/MS - elaborar procedimento obrigatório, para gestão e acompanhamento dos IES de aquisição centralizada, nos casos em que haja previsão de entrega diretamente nos entes subnacionais.

Recomendação 19 (Achados 3, 4.1.2, 4.2.2, 4.2.3 e 4.1.5) – À SE/MS - incluir, na Portaria GM/MS nº 4.777/2022, ou em outro ato normativo que a venha substituir:

a) Definir critérios obrigatórios e objetivos para o recebimento de insumos estratégicos em saúde considerando o prazo de validade disponível (vida útil) quando da data de recebimento do insumo;
b) Dispositivo que preveja a definição de critérios para o recebimento de insumos estratégicos em saúde por doação, considerando, no mínimo, a obrigatoriedade da previsão de utilização dos insumos, prazos mínimos de validade e motivação justificada para o recebimento;
c) Incluir, no Artigo 22, a determinação de que o monitoramento periódico de estoques de insumos estratégicos em saúde contemple insumos armazenados no Centro de Distribuição e nos entes subnacionais;
d) Incluir, no Artigo 22, a descrição das etapas do processo de monitoramento periódico de insumos armazenados no Centro de Distribuição e nos entes subnacionais, em substituição ou em complemento ao termo “evolução da demanda”;
e) Hierarquizar as ações preventivas a serem adotadas para que o insumo possa ser utilizado sem perda de validade, previstas no Artigo 22, contendo o decurso de prazo mínimo e máximo para que cada ação seja iniciada e concluída;

f) Definir, no preâmbulo da Portaria, o conceito "iminência de perda por decurso de validade", utilizado no inciso I do art. 23;
g) Detalhar, no Artigo 28, a Unidade do MS que será responsável pela apuração de responsabilidade, consoante inciso VIII, art. 8º, Decreto 11.098/2022;
h) Definir, no preâmbulo da Portaria, o conceito de perda de insumos estratégicos em saúde

Recomendação 20 (Achado 4.1.2) - À SE/MS - incluir no patrimônio e no sistema de controle de estoques, as informações de entrada, saída e controle de estoque dos insumos de aquisição centralizada, quer sejam entregues ou não diretamente aos entes subnacionais, consoante comandos definidos no art. 18, § 1º da Portaria GM/MS 4.777/2022.

Recomendação 21 (Achado 4.1.4) - À SE/MS - estabelecer mecanismos de controle que garantam o cumprimento do fluxo de comunicação previsto nos artigos 24 e 25 da Portaria GM/MS nº 4.777/2022, tais como elaboração de indicadores, alertas de limites de prazo e utilização de ferramentas de gestão.

Recomendação 22 (Achado 4.1.5) – À SE/MS - elaborar e implementar o mapeamento de riscos e controles do macroprocesso Gestão de Insumos Estratégicos aplicados à Saúde.

CONCLUSÃO

A Gestão de IES é assunto relevante em razão de se tratar de macroprocesso finalístico do Ministério da Saúde. Possui expressiva materialidade, superando o montante de R$ 13 bilhões em aquisições no exercício de 2023. Ademais, o tema mostrou-se crítico tendo em vista que a CGU constatou, mediante os relatórios de Auditoria Anual de Contas 2022 e 2023, registros contábeis equivocados, distorções de informações nos sistemas informatizados e fragilidades nos procedimentos de gestão de estoques IES.

As perdas efetivas, durante o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2023, de IES descartados por vencimento da data da validade contém insumos ligados à pandemia de Covid-19 (R$ 2 bilhões), insumos adquiridos por determinação judicial (R$ 24 milhões) e os demais insumos, que são comumente adquiridos pelo Ministério (R$ 213 milhões).

Além dessas, há outras situações que podem caracterizar perda potencial de insumos. Foi possível verificar a ocorrência de: a) destinações de IES após o vencimento da validade para entidade diferente de empresas que realizam o descarte, no montante de R$ 246.722.585,36, não dimensionadas como perda, tendo em vista que não foram formalmente designados para o processo de descarte; b) destinações de IES para entidades voltadas à pesquisa científica e capacitações, no montante de R$ 278.273.026,52, em detrimento da utilização para os fins originalmente previstos, e o montante não foi adequadamente dimensionado como perda; c) destinações de IES, aos entes subnacionais, próximas do vencimento da validade e com prazo exíguo para utilização, no montante de R$ 4.464.652.043,48, incorrendo em risco substancial de perdas, sendo confirmado pelos estados da federação que parcelas desses insumos foram descartadas. As perdas demonstraram-se expressivas nos estoques subnacionais, documentadas tanto pelo SIES quanto pela BNAFAR.

Todas essas situações contribuem para uma perda potencial calculada no montante de R$ 4.989.647.655,36, exercendo um impacto direto na programação de medicamentos para novas aquisições e perpetuando o ciclo de perdas.

Os principais fatores relacionados à ocorrência de perdas efetivas e potenciais de IES foram:

> Inexistência de parâmetros definidos para perdas que seriam consideradas aceitáveis. No período analisado, diferentes IES geridos pelo MS apresentaram diversos percentuais de perda, variando de 0,17% a 98% do quantitativo adquirido, apresentando uma média de 2,91% para a amostra analisada. A ausência de limites definidos para perdas pode resultar em desperdício de recursos financeiros, escassez de insumos essenciais e dificuldade em melhorar os processos de gestão. Em contrapartida, ao adotar e implementar um percentual aceitável de perdas, o MS pode potencialmente promover uma gestão mais eficiente dos recursos, reduzir desperdícios e garantir a disponibilidade adequada de insumos para a prestação de serviços de saúde à população.

A CGU examinou os comandos da Portaria GM/MS nº 4.777/2022, que regula os procedimentos de planejamento, aquisição e gestão de insumos estratégicos em saúde, e constatou inadequações de aspectos relevantes desse normativo infralegal, a exemplo de falhas na definição de termos e ausência de critérios para recebimento de insumos.

Além disso, também houve descumprimento de dispositivos da portaria, referentes às ações de prevenção de perdas de IES, sobretudo quanto à comunicação entre o DLOG, as Secretarias Finalísticas e a Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde.

Outrossim, o Sistema Integrado de Administração de Material (SISMAT), principal sistema responsável pela gestão de IES no Ministério da Saúde, é intempestivo quanto ao registro de movimentações de estoques e apresenta elevado índice de erros nos registros de medicamentos e insumos estratégicos para a saúde. Auditorias anteriores da Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas da União já abordaram a matéria da substituição do SISMAT por outro sistema que efetivamente realize a gestão patrimonial dos IES adquiridos pela União e distribuídos aos entes subnacionais.

Ainda, houve perda de insumos recebidos por meio de doação, por vencimento do prazo de validade, em razão de ausência de critérios institucionalizados acerca da previsão de utilização desses insumos, prazos mínimos de validade ou motivação pelo recebimento das doações.

Faz-se mister destacar que o Ministério da Saúde perdeu 26 lotes de insumos recebidos, no Centro de Distribuição, com mais de 30% de vida útil transcorrida, tendo em vista a ausência de critérios institucionalizados para o recebimento de insumos que considerem a relação entre a data de fabricação, a data de validade e a data de recebimento do insumo.

A perda de IES por decurso do prazo de validade contribui diretamente para a redução do impacto das políticas públicas de saúde, uma vez que diminui a disponibilidade de medicamentos, vacinas e demais materiais médico-hospitalares para a população; leva ao aumento de custos operacionais com manejo e incineração; e prejudica planejamentos futuros de aquisição, haja visto que o insumo descartado por perda da validade não reflete a real demanda da sociedade.

ANEXOS

I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

Achado nº 1

Não houve manifestação da unidade examinada.

Achado nº 2

Manifestação da unidade examinada

Por meio do Ofício 114/2025/CGDOC/AECI/MS, de 10.02.2025, o MS encaminhou a seguinte manifestação:

9. Quanto ao Achado 2, que analisou informações quanto à composição das perdas dos insumos descartados por vencimento da data de validade, tendo em vista que não foi possível reproduzir os mesmos resultados apresentados pela CGU em algumas análises, restou prejudicada a análise por parte das áreas técnicas afetas, sendo necessários esclarecimentos adicionais entre a equipe de auditoria e esta Pasta sobre a metodologia empregada para os resultados comparativos entre as planilhas de Vencidos (0038325226).

10. Um exemplo é o cálculo do quantitativo inicial necessário para a aquisição de insumos (ex.: insulina), que é baseado em estimativas populacionais e impactos orçamentários, considerando o fato de ter sido a primeira aquisição e tendo a ausência de histórico prévio de consumo dificultado a adequação das compras de medicamentos como insulina análoga, desmopressina (comprimidos) e biotina.

11. Outra questão a ser considerada são as limitações do sistema SISMAT, que comprometeram a confiabilidade dos registros avaliados, levando a divergências nas quantidades e a iniciativas para substituição pelo SIADS, um sistema mais moderno e integrado.

12. Em resposta ao referido Achado, as áreas técnicas se manifestaram, resumidamente, nos seguintes termos:

SVSA/MS: Nos termos do Despacho COEX/SVSA (0045418064), o Departamento do Programa Nacional de Imunizações – DPNI/SVSA/ME esclarece que:

> Nos programas de imunização existem dois tipos de perdas (físicas e técnicas). Cada uma é esperada em alguma parte da cadeia. Para realizar qualquer análise sobre perda é fundamental verificar a disponibilidade, qualidade e completitude de dados sobre este tópico em todos os pontos (unidades de recebimento e distribuição de

> vacinas) na cadeia de suprimento do Programa. Sem isto, qualquer inferência sobre o assunto pode fornecer resultados imprecisos.
>
> Tudo relacionado à Covid-19 deve ser analisado em contexto próprio considerando as características socioeconômicas e de alto risco em saúde pública daquele período. A perda de vacinas contra a COVID-19 foi um problema global, afetando tanto países de alta quanto de baixa renda (Journal of Global Health Reports, 2022; Vaccine, 2021). Um levantamento global revelou taxas de desperdício que variaram amplamente entre os países (International Journal of Health Planning and Management, 2022). De acordo com dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, aproximadamente 82,1 milhões de doses de vacinas contra a COVID-19 foram descartadas no país até maio de 2022 (Yahoo News, 2022).

Nesse sentido, a SVSA/MS esclarece na referida manifestação que:

> Para reduzir perdas, o PNI trabalha com os estados para redefinir cotas mensais por vacinas, realiza qualificação de recursos humanos em sala de vacina, rede de frio e sistema de informação, dentre outros, com o intuito de capacitar os profissionais que atuam na área de imunizações, quanto ao manejo e gerenciamento adequado dos imunobiológicos, com vistas a evitar perdas de qualquer natureza. Todas as orientações para boas práticas de armazenamento e transporte são realizadas em todos os webnários, informes técnicos e notas técnicas orientativas.
>
> Ainda, o PNI recomenda a adoção de medidas para a redução de oportunidades perdidas nos serviços de saúde e otimização do uso após abertura dos frascos, bem como o monitoramento de forma constante dos estoques (gerais e estratégicos), tendo como ferramenta o SIES e o Formulário de ocorrência de excursão de temperatura (para o registro de perdas técnicas), disponível em <https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=EJA3M8JE3T>, possibilitando o gerenciamento, o planejamento e a distribuição interna dos imunobiológicos, com base na população-alvo estimada para cada imunizante, estratégias de vacinação implementadas, data de validade dos lotes disponíveis em estoque.

SECTICS/MS: Com relação à análise sobre as perdas efetivas componente especializado da assistência farmacêutica, o Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos -DAF/SECTICS/MS manifestou-se por meio da Nota Técnica nº 99/2024-DAF/SECTICS/MS (0045043053), na qual destacou que, com relação à Tabela 1, da página 12 do Relatório de Avaliação Preliminar n. 1452250 (0043930887):

> (...) A CGU esclarece que a tabela foi elaborada a partir de informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, mas não especifica quais foram os documentos que embasaram a construção de tais conclusões. Nesse sentido, foi necessário o envio da fonte de dados por parte da CGU (0045464911) para que fosse realizada análise. (...)

Nesse sentido, considerando os apontamentos realizados, após a análise da CGCEAF/DAF, foi apresentado um novo cenário para o Programa de Medicamentos Excepcionais, bem como destacaram-se as justificativas dispostas nas Notas Técnicas: 416 (0045464229, p. 1-7), 666 (0045464229, p. 31-33) e 765 (0045464229, p. 11-13)

Análise da equipe de auditoria

Quanto ao item 9, a princípio, cabe ressaltar que todas as análises de dados conduzidas por esta CGU que tenham, em última instância, gerado resultados que integram este relatório, foram feitas exclusivamente sobre as bases de dados fornecidas pelo MS na forma de respostas às Solicitações de Auditoria emitidas durante o curso deste trabalho. No mais, foram encaminhados ao MS os papéis de trabalho elaborados por esta CGU durante a execução dos testes de auditoria como forma de sanar quaisquer desentendimentos que possam ter surgido quanto à metodologia empregada na análise dos quantitativos e valores de insumos perdidos.

Quanto ao item 11, o SISMAT, por sua vez, em que pese possua limitações já conhecidas tanto pelo MS quanto pela CGU, conforme explicitado no ponto 4.1.3 deste relatório, permanece sendo o sistema informatizado utilizado pelo MS em suas atividades de controle de estoques. Por esse motivo, até que o sistema seja aprimorado em suas deficiências ou substituído inteiramente por outro mais capaz, não há como deixar de evidenciar tais limitações enquanto fatores de risco para a gestão eficiente dos insumos de saúde.

Em referência ao item 12, o posicionamento da SVSA não indica óbice ao cumprimento da Recomendação 1 emitida à unidade. Adicionalmente, em reconhecimento à situação adversa no cenário da saúde pública brasileira gerada pela pandemia de Covid-19, foi redigido um novo parágrafo para integrar a análise do fato do Achado 2, de modo a levar em consideração os efeitos da pandemia.

Ainda em referência ao item 12, no que diz respeito ao cenário proposto pela SECTICS, este considera o valor total do orçamento utilizado no período de 2021 a 2023 com a aquisição dos medicamentos do componente estratégico; ou seja, a análise propõe confrontar os quantitativos totais adquiridos pelo MS com os quantitativos de perdas analisados pela CGU. Entretanto, tal proposta não apresenta evidências de que contém apenas os insumos adquiridos de forma centralizada, que possam ter vindo a expirar dentro do almoxarifado central do MS – aqueles analisados no escopo desta auditoria –, mas é possível que também tenham sido considerados em seu cômputo os insumos adquiridos mediante entrega descentralizada, realizada diretamente nos entes subnacionais. É importante considerar tal detalhe, uma vez que os insumos de aquisição centralizada e entrega direta nos entes subnacionais não entraram no cálculo originalmente feito pela CGU dos insumos descartados, o que acaba por aumentar o risco de distorção dos resultados da análise.

Assim sendo, não há evidências suficientes para suportar a conclusão de que não tenham ocorrido perdas significativas de insumos nos almoxarifados dos entes subnacionais, adquiridos pelo MS mediante entrega descentralizada, de modo que o cenário proposto pela SECTICS não encontra respaldo na fundamentação metodológica proposta por este trabalho.

Achado nº 3

Manifestação da unidade examinada

Por meio do Ofício nº 114/2025/CGDOC/AECI/MS, de 10.02.2025 o MS encaminhou a seguinte manifestação:

"Achado 3. Análise sobre as perdas em potencial (sugestão de substituição para risco de prejuízo ou risco potencial)

[...]

14. Em resposta ao referido Achado, as áreas técnicas se manifestaram, resumidamente, nos seguintes termos:

Com relação ao Achado 3, nos termos da Nota Técnica nº 99/2024-DAF/SECTICS/MS (0045043053), a área técnica da SECTICS/MS ressalta, inicialmente, que, se a análise da CGU trata sobre hipóteses que não indicam perdas necessariamente concretizadas, sugere-se que a nomenclatura "perdas" seja reanalisada, uma vez que podem se confundir com casos de perdas que efetivamente não puderam ser evitadas, ainda mais diante de um número expressivo, que totalizaria 4,4 bilhões (2021 – 2023).

Com relação aos subitens, manifesta-se, em síntese, nos seguintes termos:

> 3.1 - Destinação de IES após o vencimento da validade para entidade diferente de empresas que realizam o descarte: ...medicamentos que foram substituídos por meio de carta de troca não devem ser incluídos e considerados como "perdas em potencial", especialmente porque a substituição pelos fornecedores representa uma medida eficaz da gestão dos insumos em saúde, não se tratando de descarte ou incineração, sendo um quesito a ser corrigido no relatório de auditoria em discussão.
>
> 3.2 - Destinação de IES para entidades voltadas a pesquisa científica e capacitações, caracterizando utilização dos insumos para fins não originalmente pretendidos: Ao analisar os painéis de trabalho utilizados pela CGU e encaminhados a esta Coordenação-Geral em 18/12/24 (Planilha - PT 3.2.xlsx), utilizando-se a aba "PT 3.2", tem-se apenas 2 medicamentos referentes ao programa Medicamentos Excepcionais: (i) imatinibe e (ii) rivastigmina. Destaca-se que o medicamento imatinibe 400 mg a entidade esteve ciente do prazo de validade. Em relação ao medicamento rivastigmina 4,5 mg, informa-se que não houve destinação por parte da CGCEAF/DAF.
>
> 3.3 - Destinação de IES próximo ao vencimento da validade e com prazo exíguo para utilização por entes subnacionais e instituições de saúde:
>
> 3.3.1 - Consultas às SES: Quando um item é enviado com validade reduzida, isso ocorre mediante acordo prévio e após avaliação sobre sua utilização em tempo hábil, sendo adequado desconsiderá-lo no cálculo de descarte. Além disso, medicamentos para condições específicas, como micoses endêmicas, são enviados diretamente do almoxarifado do MS às unidades em que são imediatamente administrados aos pacientes, garantindo que sejam utilizados sem risco de vencimento.

3.3.2 - Estoques nos estados e municípios de acordo com os dados da BNAFAR e SIES: a área técnica destaca que esse dado não pode ser considerado qualificado para a conclusão pretendida, uma vez que o MS já havia comunicado ao órgão de controle interno as fragilidades verificadas na arquitetura e em scripts, indicando a necessidade de correção e aperfeiçoamento de maneira que a fidedignidade e representatividade dos dados seja assegurada. Ademais, ressalta-se que o DAF/SECTICS, em parceria com o Departamento de Monitoramento, Avaliação e Disseminação de Informações Estratégicas em Saúde (DEMAS/SEIDIGI), e seguindo as diretrizes do Plano de Dados Abertos do MS, acompanhado pela CGU, está em discussão para o desenvolvimento de um datalake para a Bnafar. Essa estrutura visa fornecer condições adequadas para a análise dos bancos de dados e garantir a conformidade com os padrões de dados abertos.

O aprimoramento da Bnafar e da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) está em fase de análise técnica no âmbito da tripartite, com o GT CIT de Informação e Saúde Digital e o GT da Ciência e Tecnologia. A proposta é repactuar o novo rol de dados, que deverá ser enviado diariamente para a base, incluindo informações sobre posição de estoque, saídas (via Bnafar) e prescrição e dispensação (via RNDS). Com isso, a Bnafar possibilitará informações oportunas para o monitoramento e avaliação dos estoques dos entes subnacionais. A pactuação dos novos modelos de dados na CIT para estoque, saídas, prescrição e dispensação está prevista para ocorrer até dezembro de 2024.

Além disso, o DAF iniciará a substituição do sistema Hórus pelo eSUS Assistência Farmacêutica (eSUSAF), um software descentralizado, de código aberto e desenvolvimento colaborativo com entes subnacionais. Esse sistema permitirá o envio diário dos dados de estoque e saídas para a Bnafar e de dispensações para a RNDS.

Por fim, o MS lançará o SISAF (Sistema Integrado de Dados da Assistência Farmacêutica), uma solução para gestão de contratos, aprimoramento da programação e distribuição em colaboração com entes subnacionais, e para monitoramento dos processos do DAF. O sistema está em fase de hospedagem na infraestrutura do Departamento de Informação e Informática do SUS (DATASUS/SEIDIGI), com previsão de testes para o primeiro trimestre de 2025.

<u>Recomendação 5 (Achado 3)</u>

[...]

38. De acordo com a área técnica da SVSA/MS, conforme o Despacho CGGI (0045402127), o PNI tem trabalhado internamente coletando as evidências científicas e práticas, como o acompanhamento das doses aplicadas e o incentivo de registro de doses perdidas pelos estados e municípios, bem como conhecendo as ferramentas disponibilizadas pela OMS, como a calculadora de perdas de vacinas (Vaccine Wastage Rates Calculator; Revising global indicative wastage rates: a WHO initiative for better planning and forecasting of vaccine supply needs, 2019), e avaliar sua viabilidade de uso no Brasil. A expectativa é utilizar as porcentagens aceitáveis de perdas no planejamento de 2026, visto que para 2025 os quantitativos já foram definidos mediante os prazos legais estabelecidos (PLOA).

39. Ademais, tendo em vista que o procedimento a que a Recomendação se refere é para identificar os insumos que não tenham sido destinados ao processo de descarte e, consequentemente, não estão contidos nas perdas calculadas efetivamente, para diminuir o impacto de "possíveis" perdas, sugere-se a substituição da nomenclatura "Perdas em Potencial" para "Risco de descarte", considerando que os números apresentados não indicam perdas necessariamente concretizadas, mas os montantes sobre os quais incidiram os riscos.

Recomendação 6 (Achado 3)

[...]

40. No que tange à presente Recomendação, a SECTICS/MS, por meio da Nota Técnica nº 99/2024- DAF/SECTICS/MS (0045043053), esclarece que o processo de aprimoramento da BNAFAR e da RNDS está em fase de análise técnica no âmbito da tripartite no GT CIT de Informação e Saúde Digital e no GT da Ciência e Tecnologia, em que será analisada pelos entes a proposta de repactuação do novo rol de dados que passará a ser obrigatório o envio para a base, com frequência diária de informações sobre posição de estoque, saídas (por meio da BNAFAR) e prescrição e dispensação (por meio da RNDS). Dessa forma, a BNAFAR possibilitará informações tempestivas para aprimoramento do processo de monitoramento e avaliação dos estoques dos entes subnacionais.

41. Portanto, a despeito das fragilidades na Bnafar e nos demais sistemas de informação, que atualmente não permitem uma gestão tão robusta quanto a desejada, para mitigar essas limitações, o departamento está investindo na modernização da Bnafar e na implementação de novas ferramentas, como o eSUSAF e o SISAF, visando aumentar a confiabilidade dos dados, a padronização das informações e o suporte à tomada de decisão, não devendo, hoje, os dados contidos na referida base ser considerados para embasar as conclusões da CGU.

Recomendação 7 (Achado 3)

[...]

42. A SESAI/MS não apresentou sugestão de alteração da Recomendação 7, destacando que alguns procedimentos de identificação da causa da perda dos itens já foram apresentados e não estão relacionados com o vencimento do item, como no caso da Ranitidina e Hipoclorito, que se impossibilitou o uso, nos termos do Relatório (0044452719), elaborado pelo Departamento de Gestão da Saúde Indígena (DGESI/SESAI).

Recomendação 8 (Achado 3)

[...]

43. A SAES/MS, por meio da Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados - CGSH/DAET/SAES/MS, destaca que possui sistemas que contribuem com o atendimento dessas Recomendações, pois está previsto o registro de utilização dos medicamentos

recebidos e campos com as respectivas informações que fornecem base de dados que podem ser analisadas, nos termos do Despacho CGSH (0044409827).

Recomendação 9 (Achado 3)

[...]

44. Com relação a esta Recomendação, conforme o Despacho CGGI (0045402127), o Ministério da Saúde anunciou uma importante iniciativa com a reestruturação da Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica (Bnafar), tornando obrigatória a atualização detalhada de informações sobre estoques, movimentação de produtos e a dispensação de medicamentos em toda a rede pública de saúde - Portaria GM/MS nº 5.713, de 9 de dezembro de 2024.

45. Com essa mudança, estados, municípios e o Distrito Federal deverão registrar de forma precisa os dados sobre os medicamentos: desde o fluxo entre centrais de abastecimento e farmácias até a entrega direta ao cidadão. Isso vale tanto para a rede pública quanto para as unidades conveniadas ao SUS. Todas as medidas foram pactuadas com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

46. Assim, sugere-se que a presente Recomendação seja demandada ao CONASS e ao CONASEMS, tendo em vista que a etapa de logística de distribuição impacta os estados e os municípios.

47. A área técnica ressalta, ainda, a atualização e reestruturação do Painel interativo de Vacinas, uma ferramenta inovadora que detalha as doses distribuídas pelo SUS desde 2023. Com dados organizados por Estado, tipo de vacina e período. Disponível online, o painel permite que todos, de gestores a cidadãos, acompanhem em tempo real a logística e o impacto do Programa Nacional de Imunizações - Painel distribuição DPNI.

Recomendação 10 (Achado 3)

[...]

48. Conforme a Nota Técnica nº 99/2024-DAF/SECTICS/MS (0045043053), em complementação aos comentários à Recomendação 6, informa-se que o DAF/SECTICS/MS deverá iniciar a substituição do sistema Hórus pelo Sistema eSUS Assistência farmacêutica (eSUSAF), que será um software de estrutura descentralizada, de código aberto e de desenvolvimento compartilhado com os entes subnacionais para sua evolução e contemplará a interoperação para envio dos dados diário dos dados de estoque e saídas para a Bnafar e dispensações para a RNDS.

49. Outra solução a ser disponibilizada pelo MS para a gestão de contratos e o aprimoramento da programação e distribuição em articulação com os entes subnacionais, bem como para aprimorar o monitoramento dos processos do DAF, será o SISAF, Sistema Integrado de dados

da Assistência Farmacêutica, que se encontra em fase de hospedagem na infraestrutura do DATASUS e com previsão de testes para o primeiro trimestre de 2025.

Recomendação 11 (Achado 3)

[...]

50. A SESAI/MS, por meio do Relatório (0044452719), elaborado pelo Departamento de Gestão da Saúde Indígena (DGESI/SESAI), esclarece que: É possível o rastreio do IES até a fase de distribuição para os Polos e UBSI dos Territórios Indígenas, e assim o monitoramento dos IES e as perdas que ocorrem dentro das Centrais de Abastecimento Farmacêutico dos Distritos estão registradas no Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica - Hórus Indígena. No entanto, pelas condições de acesso, condições climáticas, falta de energia e internet, a produção de informações sobre monitoramento de estoques vai se tornando mais frágil quanto mais próximo da dispensação ao indígena, sendo que em muitos casos o registro e armazenamento de informações de estoque se dá em formulários físicos para, após o retorno das equipes dos territórios, ser repassado aos formulários eletrônicos.

[...]

52. Com relação às Recomendações 9, 10, 11 e 12, seria interessante que a CGU também demandasse as referidas recomendações ao CONASS e ao CONASEMS, tendo em vista que a etapa de logística de distribuição impacta os estados e os municípios.

Recomendação 13 (Achado 3)

[...]

53. Com relação à presente recomendação, de acordo com o Despacho CGGI 0045402127, o DPNI/SVSA/MS realizou um levantamento junto aos estados em janeiro de 2023 sobre os tempos de entrega nas diferentes unidades federadas, para aprimorar os tempos de envio de imunobiológicos. Assim, o levantamento demonstrou que a logística de entrega das vacinas até os estados leva de 7 a 15 dias, em média, enquanto a logística de distribuição interna nos estados para seus municípios varia conforme disponibilidade de transporte e distância, podendo chegar a mais de 30 dias após o recebimento na central estadual. Desta forma, o PNI prioriza o envio de vacinas com validade superior a 90 dias. Em casos excepcionais, para o necessário abastecimento, o Programa negocia o recebimento pelos estados de validades inferiores a esse prazo.

Recomendação 14 (Achado 3)

[...]

55. De acordo com os comentários da área técnica, mediante a Nota Técnica nº 99/2024-DAF/SECTICS/MS (0045043053), no caso da entrega centralizada e sua posterior distribuição às SESs e SMSs, este Departamento entende que o DLOG dispõe de dados relativos ao tempo

necessário para a efetivação do processo. Para as entregas descentralizadas, aplica-se o prazo estabelecido no contrato, geralmente definido com base na cobertura dos estoques disponíveis nas localidades. É importante destacar que a distribuição e dispensação dos medicamentos aos usuários dos três componentes da assistência farmacêutica são de responsabilidade exclusiva das SESs e do DF, cabendo a elas o planejamento e a execução da logística de distribuição.

56. Conforme o art. 107 da PRC GM/MS nº 02/2017, "Após a entrega dos medicamentos de aquisição centralizada pelo MS para as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, toda a logística restante será de responsabilidade exclusiva das citadas Secretarias". Dessa forma, presume-se que os estados e o DF estão alinhados aos cronogramas definidos, assegurando o acesso oportuno aos medicamentos.

Recomendação 15 (Achado 3)

[...]

57. Conforme relatório (0044452719), do Departamento de Gestão da Saúde Indígena (DGESI/SESAI), a limitação encontrada é elaborar estudos específicos por estado da federação (DSEI), que detalhem o tempo logístico mínimo necessário como critério para distribuição de cada grupo de insumo até a dispensação final ao usuário, tendo em vista que os prazos logísticos sofrem variação com as mudanças climáticas, logística aérea, terrestre e fluvial, que também está diretamente relacionada a entrada da equipe de saúde nos territórios. Como referido anteriormente, disponibilidade de internet, falta de energia, trafegabilidade dos rios, condições de voo, disponibilidade de combustível e horas voo, escala dos funcionários e periodicidade das pautas de distribuição, são alguns dos elementos que impactam o tempo logístico de distribuição dos insumos por DSEI. O que existe atualmente, a partir de 2024, é um monitoramento e estudo do tempo médio de distribuição dos insumos do almoxarifado central até a CAF do DSEI, considerando o momento de saída e recebimento, assim como condições climáticas.

Recomendação 16 (Achado 3)

[...]

58. A Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados - CGSH/DAET/SAES/MS, por meio do Despacho CGSH (0044409827), destaca que monitora os prazos gastos na logística de distribuição aos estados, porém não possui instrumento padronizado de referência.

59. Propõe-se que as Recomendações 14, 15 e 16 sejam desconsideradas, mantendo-se apenas a Recomendação 13, direcionada à SVSA/MS, para que elabore, em conjunto com o DLOG/SE/MS, CONASS e CONASEMS, estudo específico que detalhe o tempo logístico mínimo necessário como critério para distribuição de cada grupo de insumo até a dispensação final ao usuário (CONASS até o Estado, e CONASEMS até o Município).

Por meio do Ofício nº 331/2025/CGDOC/AECI/MS, de 01.04.2025, o MS encaminhou manifestação complementar

"**5.** Destaca-se que, após a nova categorização do "programa de saúde", houve redução do valor indicado para o DAF, conforme consta do Despacho CGLOG (SEI nº 0046870006), visto que não se tratava de perda em potencial, mas sim reposição do insumo por meio de carta de troca, conforme abaixo transcrito:

6. Nesse sentido, as considerações acima apresentam as justificativas solicitadas no parágrafo 4.7 da NOTA TÉCNICA Nº 99/2024-DAF/SECTICS/MS (0045043053). Observa-se que o valor total das incinerações do Programa de Saúde Medicamentos Excepcionais, conforme informado na 1ª planilha enviada, era de R$ 42.737.689,71 considerando os anos de 2021 a 2023. No entanto, com base nas informações acima, sugere-se o abatimento de R$ 2.799.601,56, uma vez que esse montante não se configura como "perda em potencial" para o referido Programa, pois foi retornado aos cofres públicos por meio da reposição dos insumos decorrente da carta de troca. (grifos próprios)"

Análise da equipe de auditoria

No item 14 a manifestação do Ministério da Saúde, levanta questões sobre a terminologia utilizada na análise da CGU em relação a manchete do Achado 3. Embora a área técnica da SECTICS/MS sugira uma reavaliação do termo "perdas", é fundamental considerar que a terminologia utilizada no relatório é "perda potencial", que aborda hipóteses de perdas de IES no âmbito do Ministério da Saúde. A utilização de "perda potencial" permite uma análise mais abrangente das vulnerabilidades e ineficiências que permeiam a gestão dos IES. Além disso há evidências tratadas no relatório, de que parte dos insumos de fato se perdeu em etapas da cadeia logística materializando o risco.

Quanto ao item 14, subitem 3.1, esclarecemos que medicamentos que foram substituídos por meio de carta de troca não foram contabilizados como perdas em potencial. A lista de insumos em questão foi submetida à análise da SECTICS por meio da Solicitação de Auditoria nº 08 e reiterada pela Solicitação de Auditoria nº 10. Os insumos para os quais houve indicação de carta de troca, à época da execução do trabalho, foram devidamente excluídos da soma total. Assim, no relatório constam apenas insumos para os quais as Secretarias não apresentaram nenhum indicativo de troca durante a fase de execução da auditoria.

Na manifestação SEI_0045043053_Nota_Tecnica_99, a SECTICS enviou quadro indicando números de ofícios de carta de troca para parte das saídas, que somam aproximadamente R$ 400 mil no montante total de R$ 246 milhões. Além disso, para outra parte dos itens, a Nota Técnica aponta a necessidade de um esclarecimento por parte do DLOG, sem que haja conhecimento da SECTICS sobre o motivo da devolução ao fabricante. Os itens nessa condição totalizam mais de R$ 3 milhões.

Em manifestação complementar por meio do Despacho DLOG/SE/MS SEI_0046802940, de 24.03.2025, o DLOG presta esclarecimentos sobre insumos incluídos nesse montante, porém não há informações suficientes para mudar a condição encontrada na auditoria. Esse

desencontro de informações entre setores do Ministério da Saúde reforça o achado de que os insumos podem ter sido potencialmente perdidos.

No item 14, subitem 3.2, o gestor não apenas confirma o achado do relatório, mas também enfatiza a incerteza quanto à destinação dos insumos para finalidades distintas das originalmente previstas.

No item 14, subitem 3.3.1, em relação à menção de acordo prévio para o envio de insumos com validade reduzida, essa circunstância não altera a conclusão de que os insumos foram enviados com prazos exíguos. As Secretarias Estaduais de Saúde consultadas durante a auditoria afirmaram que, devido ao risco de desabastecimento, seria inviável para estados e municípios recusarem insumos próximos do vencimento. O Ministério da Saúde informou que alguns insumos são enviados diretamente do almoxarifado do MS para as unidades, onde são imediatamente administrados aos pacientes. Embora essa prática minimize o risco de perda, ainda existe a possibilidade de que os insumos não sejam utilizados a tempo. Portanto, é fundamental realizar um estudo como critério para validade mínima de distribuição que considere o tempo logístico de cada tipo de medicamento, de acordo com seu fluxo de entrega.

No item 14, subitem 3.3.2, em relação ao uso dos dados da BNAFAR e do SIES no relatório de auditoria, o Ministério da Saúde ressalta que esses dados não podem ser considerados totalmente qualificados. No entanto, é importante reconhecer que, embora possam não ser completamente fidedignos, foram utilizados no Relatório, apenas como exemplos, com essa ressalva. Embora essa abordagem não tenha sido a ideal, foi a única opção presentada pelo MS na época dos fatos e também a opção disponível para os controles do MS. Além disso, o gestor informa que o DAF/SECTICS está trabalhando para aprimorar a análise de dados e a repactuação do novo rol de dados para o monitoramento de estoques e dispensação na CIT. Essa iniciativa é positiva e demonstra um avanço, que deverá ser acompanhado e monitorado no atendimento das recomendações 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

No item 43, em relação aos sistemas mencionados pela SAES, cujas informações estariam alinhadas com a recomendação 8, a CGU irá, ao monitorar o cumprimento das recomendações, examinar os registros do sistema citado para determinar se a recomendação foi efetivamente atendida.

Com relação aos itens 44 a 47, a manifestação da CGCI reforça a necessidade da implementação de mecanismos de relato e informa que ausência de um sistema nacional integrado compromete a eficiência e a confiabilidade no fluxo de dados entre as diversas instâncias de gestão, o que resulta em lacunas e atrasos na consolidação de informações imprescindíveis ao adequado planejamento e monitoramento da gestão de insumos. A Portaria GM/MS nº 5.713, de 9.12.2024, recentemente publicada pelo Ministério da Saúde, estabelece os modelos de informação que devem ser adotados pelos entes federados, além dos sistemas que compõem a BNAFAR/SUS. A portaria determina que o Registro Eletrônico de Saída por Movimentação ou Perda de Estoque (RESMPE) deve incluir, entre outras informações, o motivo da saída do estoque. A conformidade com a Recomendação 9 dependerá da forma como esses dados forem registrados. O monitoramento da

recomendação pela CGU avaliará se essa informação é registrada em campo de livre escrita ou se são oferecidas opções pré-definidas pelo sistema, e se o Painel Interativo de Vacinas, citado na manifestação, elucida relato de perdas em todas as etapas da cadeia logística.

Nos itens 48 e 49, sobre a substituição do sistema Hórus pelo eSUS, o gestor menciona as melhorias planejadas que serão monitoradas pela CGU durante a fase de acompanhamento das recomendações. Da mesma forma, quanto a solução Sistema Integrado de dados da Assistência Farmacêutica (SISAF). O processo de monitoramento é crucial para garantir que as melhorias propostas sejam efetivamente implementadas e que atendam às recomendações propostas.

No item 50, a SESAI informa que realiza o monitoramento das perdas por meio do sistema Hórus Indígena. Nesse contexto, a CGU avaliará se as informações registradas abrangem os relatos de perdas de uma maneira mais ampla, considerando uma definição que vai além da simples incineração. Essa análise é fundamental para garantir que todos os tipos de perdas sejam devidamente contabilizados e tratados.

No item 53, a SVSA informou sobre um levantamento realizado em 2023 a respeito da logística de distribuição de imunobiológicos, destacando que o Programa Nacional de Imunizações (PNI) prioriza o envio de vacinas com validade superior a 90 dias. A CGU acompanhará, durante o monitoramento da recomendação, se esse estudo será utilizado como critério para a distribuição de cada grupo de insumos até a dispensação final ao usuário. Isso é especialmente relevante, considerando que a auditoria identificou milhares de insumos, incluindo imunobiológicos, destinados aos estados com validade inferior a 90 dias.

Quanto aos itens 55 e 56, a SECTICS sugere que o DLOG seria responsável pelo controle dos dados relacionados ao tempo logístico necessário para a distribuição de insumos a partir do Centro de Distribuição. No entanto, o próprio DLOG, em sua manifestação – Despacho SEI_0045088768 – confirma que:

> no caso de entregas centralizadas (ou seja, entrega realizada pelo fornecedor diretamente no Centro de Distribuição desta Pasta em Guarulhos - SP), após o recebimento do insumo, a distribuição aos estados passará a ser executada somente após os pedidos feitos pelo requisitante, que é responsável por avaliar a necessidade do insumo em cada localidade...

E ainda que:

> o processo decisório dentro da cadeia logística dos IES é de responsabilidade exclusiva da área requisitante, sem qualquer ingerência do DLOG nas escolhas e diretrizes estabelecidas. Nesse contexto, cabe à área técnica requisitante:
> Definir os insumos e os quantitativos a serem adquiridos;
> Deliberar sobre os envios aos estados; e
> Adotar as medidas necessárias para evitar a perda dos IES.

Em relação ao artigo 107 da PRC GM/MS nº 02/2017, mencionado no item 56 da manifestação, que trata da responsabilidade exclusiva das Secretarias em relação à logística, é importante destacar que esse ponto não se relaciona diretamente com a questão levantada na recomendação, que se refere ao tempo de vida útil dos insumos ao saírem do Centro de Distribuição. Para que as Secretarias possam garantir o acesso oportuno aos medicamentos, é essencial que estes cheguem com uma validade adequada. Apenas um estudo detalhado poderá determinar qual é a validade necessária para assegurar que os insumos sejam efetivos e seguros para uso, considerando as discrepantes realidades do território brasileiro.

No item 57 a SESAI menciona um estudo que analisa o tempo médio de distribuição dos insumos desde o almoxarifado central até a Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) do DSEI. Esse estudo pode servir como fonte de dados para calcular o tempo logístico mínimo necessário, que deve ser considerado como critério para a validade dos insumos no momento da saída do Centro de Distribuição. A CGU acompanhará, no decorrer do monitoramento da recomendação, se esse estudo será efetivamente utilizado como parâmetro para definir validade mínima na distribuição de cada grupo de insumos até a entrega final ao usuário. Essa abordagem garantirá que os insumos sejam disponibilizados com a validade adequada, promovendo a segurança e a eficácia no atendimento à saúde.

No item 58 a manifestação da CGSH/DAET/SAES/MS indica que, atualmente, não existe um instrumento padronizado que estabeleça critérios de validade mínima para a distribuição de cada grupo de insumos até a dispensação final ao usuário. Essa lacuna evidencia a necessidade de desenvolver estudos específicos em cada estado da federação, que detalhem o tempo logístico mínimo necessário para a distribuição. A elaboração desses estudos é fundamental para garantir que os insumos cheguem aos usuários com a validade adequada, assegurando a eficácia e a segurança dos medicamentos e outros produtos de saúde.

Achado nº 4

Manifestação da unidade examinada

Por meio do Ofício nº 114/2025/CGDOC/AECI/MS, de 10.02.2025, o MS encaminhou a seguinte manifestação:

15. Nos termos do Achado apresenta análises realizadas sobre fatores que merecem debate e aprimoramento, pelo potencial de impacto nas perdas efetivas e potenciais, agrupados em duas categorias de análise: controles administrativos e logística, subdividindo-se em:

4.1. Fatores relacionados a controles administrativos
4.1.1. Inexistência de parâmetros de aceitabilidade de perdas por parte do Ministério da Saúde.
4.1.2. Fragilidades nos controles sobre o montante de perdas físicas e técnicas de insumos de aquisição centralizada, ocorridas nos entes subnacionais.
4.1.3. Inadequações do Sistema SISMAT, registradas em relatórios anteriores da CGU e do TCU, com recomendação de substituição do sistema.

4.1.4. Descumprimento da Portaria GM/MS nº 4.777/2022, referente às ações para prevenção de perda de Insumos Estratégicos em Saúde.
4.1.5 Inadequações em termos e dispositivos da PORTARIA GM/MS nº 4.777/2022, que regula os procedimentos de planejamento, aquisição e gestão de IES.
4.2. Fatores relacionados à logística
4.2.1. Tempo de Transporte do Operador Logístico.
4.2.2. Recebimento de insumos, no Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, com validade inferior a 70% do seu prazo de vida útil.
4.2.3. Ausência de critérios mínimos para recebimento de doações, tendo havido perdas de IES doados por decurso do prazo de validade.

16. Em resposta ao referido Achado, as áreas técnicas se manifestaram, resumidamente, nos seguintes termos:

17. Com relação ao item 4.1.1 do Achado 4, a **SAES/MS**, por meio do Despacho CGOEX/SAES (0044436776), que referencia a manifestação do Departamento de Atenção Especializada e Temática (DAET/SAES/MS), conforme Despacho CGSH (0044409827), esclarece que para que seja estabelecida tal referência é necessário que seja realizado o levantamento e análise das perdas considerando as demais aquisições demandadas por esta área finalística, não apenas a situação específica da desmopressina adquirida pela CGSH/SAES indicada neste relatório, por ter sido uma situação excepcional. Desta forma, a porcentagem de 39,50% não reflete a realidade do percentual de perdas considerando todos os contratos de aquisição realizados, e não poder ser considerada no levantamento de parâmetros.

18. A SVSA/MS, por sua vez, estaca que o Departamento do Programa Nacional de Imunizações – DPNI/SVSA/MS esclarece que, no que diz respeito à proposta de parâmetros para análise de perda a ser utilizada, é necessário primeiramente avaliar:

> I - A qualidade e quantidade dos dados disponíveis;
> II - Local/Sistema onde estão armazenados;
> III - O tempo de análise retrospectivo deve ser maior que os últimos 5 anos considerando que outros fatores epidemiológicos e de abastecimento podem influenciar o período pré-pandemia; além disso, também é importante identificar a mudança de comportamento social de adesão da população durante a pandemia não apenas para vacina covid-19, mas também para as demais vacinas do calendário.
> IV - Analisar o total de doses adquiridas para o público-alvo planejado quanto as doses efetivamente aplicadas, segmentadas por faixa etária.

(...)

19. Ainda com relação ao Achado 4.1.1, nos termos da Nota Técnica nº99/2024-DAF/SECTICS/MS (0045043053), a área técnica da SECTICS/MS ressalta que:

> Para medicamentos destinados ao tratamento de doenças crônicas, há uma dificuldade em estimar um percentual de perdas, mesmo diante de demandas previamente estabelecidas, dados os diversos fatores que podem influenciar o consumo desses medicamentos. Deve-se considerar que estados e municípios possuem autonomia para elaborar listas próprias de medicamentos, com

> financiamento e aquisição sob sua responsabilidade. Nesse contexto, a introdução de novas tecnologias pode impactar significativamente a demanda por medicamentos já adquiridos de forma centralizada para as mesmas indicações.
>
> Em relação aos medicamentos voltados para o tratamento de doenças transmissíveis, a oscilação no número de casos de um ano para outro pode ser substancial, especialmente no caso de doenças transmitidas por vetores ou doenças virais. Tal variabilidade dificulta o estabelecimento de parâmetros de aceitabilidade de perdas. Além disso, eventos como surtos inesperados, alterações climáticas e deslocamentos populacionais configuram fatores que tornam ainda mais desafiadora a definição de percentuais aceitáveis de perdas de IES nesses casos.
>
> Outro aspecto relevante refere-se aos casos em que não se espera demanda contínua pelo IES, mas que, ainda assim, sua aquisição é imprescindível. Esse é o caso de insumos destinados a situações de calamidade ou emergências em saúde pública. A título exemplificativo, destaca-se o medicamento hidroxocobalamina, utilizado no tratamento de intoxicações por cianeto – condição frequentemente associada à inalação de fumaça em incêndios. Para esses tipos de medicamentos, espera-se a perda integral (100%) do estoque adquirido, considerando a necessidade da sua disponibilidade em tempo oportuno em todo o território nacional.

20. No que tange ao item 4.1.2, a **SAES/MS**, por meio do Despacho CGOEX/SAES (0044436776), em citação à manifestação da área técnica do DAET/SAES/MS (0044409827), destaca que a maior fragilidade neste aspecto diz respeito à análise das informações registradas nos sistemas (SHWC e SHWH), que depende da adequada alimentação pelos centros de tratamento. Dessa forma, orienta-se constantemente os estados para a atualização das informações quanto à dispensação dos medicamentos, conferência de estoque físico e estoque virtual e baixa de medicamentos utilizados ainda presentes em estoque virtual, bem como baixa de medicamentos não utilizados e expirados.

21. Com relação aos fatores relacionados à logística, destacados no item 4.2 do Achado 4, a Coordenação-Geral de Logística – CGLOG/DLOG/SE/MS esclarece que realiza um monitoramento rigoroso dos insumos estratégicos em saúde (IES) armazenados no Centro de Distribuição de Guarulhos/SP. Esse monitoramento abrange o registro detalhado de todas as operações de entrada, saída e movimentação de estoques, com o objetivo de garantir a integridade dos insumos, prevenir perdas e assegurar a disponibilidade adequada para atender à demanda nacional, em conformidade com o art.18, § 1º, da Portaria GM/MS nº 4.777/2022.

22. Para o controle dos estoques, a CGLOG utiliza o Sistema de Materiais (SISMAT), uma plataforma exclusiva para a gestão dos insumos armazenados no Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, enquanto estes aguardam distribuição para as 27 Secretarias Estaduais de Saúde.

23. Quanto aos insumos entregues diretamente aos entes subnacionais, o processo inclui a supervisão de fiscais e gestores de contrato, que realizam a fiscalização à distância para a liquidação da despesa. Paralelamente, as 27 Secretarias Estaduais realizam o recebimento físico dos insumos e registram as informações nos sistemas competentes. Cada Secretaria Estadual adota um modelo operacional específico, sendo que os insumos podem ser recebidos

em centros de distribuição próprios ou terceirizados. Esse processo é crucial para que os entes subnacionais acompanhem com precisão o fluxo de insumos, evitando faltas e assegurando a equidade no acesso a recursos essenciais, além de garantir maior celeridade na distribuição, especialmente em regiões remotas ou com alta demanda.

24. Cabe destacar que, no âmbito da Federação, não há subordinação hierárquica entre os entes federativos, diferentemente de uma estrutura administrativa vertical dentro de uma mesma esfera de governo. Cada ente possui autonomia administrativa, financeira e política. No entanto, é possível que esses entes atuem de forma cooperativa para aumentar a efetividade das políticas públicas, como exemplificado pelo cadastro de informações sobre dispensações nos sistemas BENAFAR, SIES, Hórus, entre outros.

25. Por fim, em que pese o SISMAT estar em fase de adequações, ele não está parametrizado para registrar os insumos cuja entrega tenha ocorrido de forma descentralizada.

Recomendações:

(Recomendação 1 – Achado 2 e 4.1.1)

26. Com relação à **Recomendação 1**, a **SVSA/MS**, por meio da Coordenação-Geral de Insumos e Rede de Frio – CGGI/DPNI/SVSA, se manifestou nos termos do Despacho CGGI (0045402127), no qual destaca: A definição das perdas de vacinas no Brasil deve considerar diversos fatores, como as diferenças nos cenários epidemiológicos entre as regiões, a variação na logística de entrega entre os estados e eventos inesperados, como epidemias, surtos e a adesão da população. Apesar do aumento recente nas coberturas vacinais, persistem resistências ao uso de certas vacinas, como a de COVID-19. Nesse contexto, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) trabalha internamente para estabelecer percentuais de perda que levem em conta essas particularidades.

27. Portanto, sugere-se que seja considerado o contexto da Pandemia, dividindo-se o valor da perda efetiva, com a retirada do valor da Covid-19.

28. Ressalta-se, ainda, que, na tabela 6 do relatório Preliminar, observa-se que as porcentagens de perda das vacinas de rotina (Calendário Nacional de Vacinação) estão alinhadas às diretrizes da OMS e outras referências disponíveis (PAHO, 2006; Nkenyi et al., 2022), com exceção das vacinas dupla viral e DTP. A vacina dupla viral, destinada à proteção contra sarampo e rubéola, foi adquirida emergencialmente no início do surto de sarampo em 2019, devido à dificuldade de o fornecedor da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) atender à demanda. Em casos de surto ou emergências, é necessário garantir grandes volumes para proteção não apenas das pessoas não vacinadas, mas também, em necessidades específicas, assim como revacinar o público vulnerável à doença. Ainda, com o início da pandemia, os estoques de todas as vacinas foram impactados com a redução de demanda pelos estados.

29. Assim, entende-se que o Relatório deve considerar o contexto do surto de sarampo, indicando o contexto, conforme comentários acima.

30. Ademais, a unidade informa que a Rede de Frio do PNI é composta por 1 central nacional, 27 centrais estaduais, 293 centrais regionais municipais, aproximadamente 4.165 centrais municipais e 37 mil salas de vacina, além de 55 centros de imunobiológicos especiais. Isto demonstra a magnitude e complexidade da cadeia de suprimento do Programa Nacional de Imunizações. Além disso, ela é gerenciada de forma tripartite, respeitando a autonomia e organização federativa.

31. Nesse sentido, a área técnica da SVSA/MS informa que, no intuito de reduzir perdas, o PNI trabalha com os estados para redefinir cotas mensais por vacinas, realiza qualificação de recursos humanos em sala de vacina, rede de frio e sistema de informação, dentre outros, com o intuito de capacitar os profissionais que atuam na área de imunizações, quanto ao manejo e gerenciamento adequado dos imunobiológicos, com vistas a evitar perdas de qualquer natureza. Todas as orientações para boas práticas de armazenamento e transporte são realizadas em todos os webinários, informes técnicos e notas técnicas orientativas.

32. Ainda, o PNI recomenda a adoção de medidas para a redução de oportunidades perdidas nos serviços de saúde e otimização do uso após abertura dos frascos, bem como o monitoramento de forma constante dos estoques (gerais e estratégicos), tendo como ferramenta o SIES e o Formulário de ocorrência de excursão de temperatura (para o registro de perdas técnicas), disponível em <https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=EJA3M8JE3T>, possibilitando o gerenciamento, o planejamento e a distribuição interna dos imunobiológicos, com base na população-alvo estimada para cada imunizante, estratégias de vacinação implementadas, data de validade dos lotes disponíveis em estoque.

(Recomendação 2 – Achado 2 e 4.1.1)

33. No que tange a essa **Recomendação 2**, a área técnica da **SECTICS/MS** informou que o Ministério da Saúde referencia-se nas recomendações da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) 2021/22 que sugerem como limite de perda aceitável o percentual de até 1% do quantitativo total de insumos adquiridos, mas é possível encontrar referências que mencionam de 3% a 5% como um limite de perda tolerável.

34. É importante mencionar que a existência de perdas não significa necessariamente ineficiência na gestão dos insumos de saúde. Nesse sentido, é legítimo que haja um quantitativo de perda esperado e controlado, como, por exemplo, em situações de Relatório Preliminar 23 tratamento de segunda linha em que os insumos precisam estar disponíveis para pacientes que não respondem aos medicamentos mais usuais.

35. Nesse sentido, o DAF/SECTICS/MS destaca que, para a avaliação de perdas, devem ser revistos os critérios utilizados para: (i) os insumos para tratamento de segunda linha; (ii) medicamentos destinados a doenças transmissíveis; (iii) IES destinados a situações de calamidade e/ou emergências em saúde pública e antídotos.

(Recomendação 3 – Achado 2 e 4.1.1)

36. A **SESAI/MS** entende que o levantamento dos percentuais aceitáveis de perda é um importante instrumento para o planejamento das aquisições e poderá auxiliar os Distritos Sanitários Especiais Indígena na programação dos medicamentos, elaborado pelo Departamento de Gestão da Saúde Indígena (DGESI/SESAI).

(Recomendação 4 – Achado 2 e 4.1.1)

37. Com relação à referida Recomendação, a **SAES/MS**, por meio do Despacho CGOEX/SAES (0044436776), encaminhou as informações prestadas peloD epartamento de Atenção Especializada e Temática (DAET/SAES/MS), conforme Despacho CGSH (0044409827), bem como pelo Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência (DAHU/SAES/MS), conforme Despacho DAHU (0044417327), destacando que é necessário que seja realizado o levantamento e análise das perdas considerando as demais aquisições demandadas pela área finalística, não apenas a situação específica da desmopressina adquirida pela CGSH/SAES, indicada no relatório, por ter sido uma situação excepcional. Desta forma, a porcentagem de 39,50% não reflete a realidade do percentual de perdas considerando todos os contratos de aquisição realizados, e não poder ser considerada no levantamento de parâmetros.

Recomendação 18 (Achado 4.1.2)

[...]

62. O DLOG/SE/MS, por meio do Despacho DLOG (0045088768), destaca que a Secretaria-Executiva está capitaneando um projeto nacional de Monitoramento de Medicamentos e **Insumos para a Saúde, o qual deverá contar com a colaboração e cooperação entre entes** subnacionais visando a solução desse problema e garantindo a efetividade das políticas públicas.

Recomendação 19 (Achados 4.2.2 e 4.2.3)

63. Conforme manifestação relativa à Recomendação 17, de acordo com o Despacho DLOG 0045088768, a demanda está sob a responsabilidade do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria GM/MS nº 5.258, de 16 de agosto de 2024, com a finalidade de revisar a Portaria GM/MS nº 4.777, de 30 de dezembro de 2022, no âmbito do Ministério da Saúde. As sugestões de alterações indicadas no Relatório de Avaliação já foram encaminhadas ao Grupo de Trabalho, e serão devidamente analisadas durante a revisão dos artigos pertinentes.

Recomendação 20 (Achado 4.1.2)

[...]

64. Nos termos do Despacho DLOG 0045088768, o Departamento de Logística em Saúde – DLOG/SE/MS esclarece que já faz a inclusão, no patrimônio e no sistema de controle de estoques, das informações de entrada, saída e controle de estoques dos IES de aquisição

centralizada entregues diretamente ao almoxarifado central de Guarulhos. Em relação à entrega diretamente aos entes subnacionais (descentralizada), tendo em vista o modelo de gestão tripartite, as 27 Secretarias Estaduais realizam o recebimento físico dos insumos e registram as informações nos sistemas competentes. Cada Secretaria Estadual adota um modelo operacional específico, sendo que os insumos podem ser recebidos em centros de distribuição próprios ou terceirizados. Esse processo é crucial para que os entes subnacionais acompanhem com precisão o fluxo de insumos, evitando faltas e assegurando a equidade no acesso a recursos essenciais, além de garantir maior celeridade na distribuição, especialmente em regiões remotas ou com alta demanda.

65. Nesse sentido, considerando que não há subordinação hierárquica entre os entes federativos, o DLOG não realiza a inclusão no patrimônio e no sistema de controle de estoques das informações de entrada, saída e controle de estoques dos IES no SISMAT. Cada Secretaria Estadual adota um modelo operacional específico, sendo que os insumos podem ser recebidos em centros de distribuição próprios ou terceirizados. Dessa forma, solicita-se a **exclusão da Recomendação.**

Recomendação 21 – Achado 4.1.4

66. De acordo com a manifestação do DLOG, já existem mecanismos de controle para o cumprimento do fluxo de comunicação previsto na Portaria GM/MS nº 4.777/2022. No entanto, o Departamento está aprimorando o procedimento. Dessa forma, sugere-se a alteração de "estabelecer mecanismos" para "aprimorar mecanismos" no teor da Recomendação.

Recomendação 22 – Achado 4.1.5

67. Em resposta à Recomendação 22, o DLOG destaca em sua necessidade de elaborar e implementar o mapeamento de riscos e controles no macroprocesso de “Gestão de Insumos Estratégicos Aplicados à Saúde”. O Departamento de Logística em Saúde - DLOG, vinculado à Secretaria Executiva - SE do Ministério da Saúde - MS, comunica que a execução dessa Recomendação será realizada de forma estruturada, com a divisão do processo em duas etapas complementares e interdependentes.

Análise da equipe de auditoria

Quanto ao item 17, a recomendação da CGU é no sentido de que seja feito o levantamento e análise de perdas considerando as principais aquisições de cada área finalística – sendo essas as aquisições em maior quantitativo de insumos, em maior valor financeiro ou de acordo com outro critério a ser definido pela área como o mais relevante –, não apenas dos insumos perdidos apresentados no relatório, cujo propósito é, em essência, exemplificativo. Neste ínterim, a CGU endossa a manifestação da unidade auditada, e a manifestação não indica que a recomendação não possa ser cumprida. No mais, reconhece-se que o percentual de 39,50% pode não refletir a realidade do percentual de perdas da área em questão, tratando-se os números levantados no relatório de uma análise exploratória a respeito do potencial ganho

de eficiência que seria obtido a partir da adoção do percentual de perda como meta de eficiência da gestão de IES.

Quanto ao item 18, a recomendação da CGU é no sentido de que seja feito o levantamento e análise de perdas considerando todos os aspectos mencionados pela unidade auditada em sua manifestação: qualidade e quantidade dos dados disponíveis, local e sistema de armazenamento dos dados, tempo de análise suficiente para produzir um percentual de perda que seja realista e passível de ser alcançado e demais questões relativas ao planejamento das aquisições. Deste modo, a CGU endossa a manifestação da unidade auditada, e a manifestação não indica que a recomendação não possa ser cumprida.

Quanto ao item 19, é mencionado no relatório de auditoria que é o Ministério da Saúde que detém, por ser a unidade gestora e detentora do conhecimento técnico necessário, as competências necessárias para definir quais insumos podem tolerar uma perda percentualmente maior sem comprometer a eficácia e a qualidade dos serviços de saúde prestados à população. Nesse sentido, entende-se que o MS também é capaz de avaliar e definir as situações nas quais a adoção de um percentual aceitável de perdas para determinados insumos levaria a resultados de baixo ou nenhum impacto positivo sobre a gestão de insumos e o controle de perdas, como no caso de insumos adquiridos pela primeira vez, ou quando adquiridos de maneira emergencial para combater eventuais surtos ou emergências de saúde pública, situações nas quais haveriam poucos dados quantitativos sobre os quais basear a adoção de um percentual de perdas razoável e factível.

Ainda, quanto aos casos mencionados pela unidade auditada, quais sejam: introdução de novas tecnologias em saúde, medicamentos voltados para o tratamento de doenças transmissíveis em que há oscilação constante na demanda, surtos inesperados e demais exemplos, reconhece-se que de fato nem todos os insumos possuem dados de consumo que possam auxiliar na definição de uma "meta de perdas" controlada e aceitável. Entretanto, também se entende não ser desejável que absolutamente nenhum insumo possua meta de perdas, situação verificada hoje no MS e apurada neste relatório.

Neste ínterim, o relatório cita um exemplo de insumo que não se espera que tenha demanda contínua, o soro antiofídico (soro utilizado em caso de acidente com serpentes peçonhentas). Nesse caso exemplificativo, o percentual aceitável da perda poderia ser definido em 100%; ou seja, uma perda de 100% do insumo adquirido seria considerada aceitável, pois é um insumo adquirido para situações excepcionais que deve estar prontamente disponível caso necessário. Isto é, não é requerido que todos os insumos adquiridos tenham suas demandas analisadas e possuam percentuais de perdas estabelecidos: é possível que apenas os insumos de demanda mais previsível tenham a "meta de perdas", ou os de maior valor agregado, ou os adquiridos em maior quantidade. Novamente, os critérios para quais insumos terão o percentual de perdas estabelecido devem ser definidos pelo Ministério da Saúde, que detém o conhecimento técnico para tanto.

Quanto ao item 26, a manifestação da unidade auditada reconhece a importância da recomendação, indicando que esta será atendida.

Quanto ao item 28, é importante ressaltar que o percentual aceitável de perdas, embora atue como uma meta e uma justificativa prévia para as perdas que venham a ocorrer dentro da quantidade previamente estimada pelo MS, não implica em responsabilização imediata em caso de descumprimento do percentual definido. O percentual aceitável de perdas trata-se, portanto, de um instrumento de gestão que visa manter os desperdícios dentro de um patamar gerenciável por meio da identificação e monitoramento de situações que possam levar a perdas excessivas de medicamentos.

Quanto ao item 33, ressalte-se que durante a etapa de execução do trabalho, a unidade auditada informou à CGU, nos termos da Nota Técnica nº 40/2023-DAF/SECTICS/MS, presente no OFÍCIO Nº 1456/2023/CGINTE/AECI/MS, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 10, que "não possui nem conhece regulamentação, no âmbito desta Pasta, que estabeleça parâmetros de aceitabilidade de perdas de insumos". Entretanto, em que pese a manifestação referenciada acuse adotar as recomendações da OPAS, a unidade auditada não apresentou evidências – como estudos técnicos, portarias regulamentadoras ou outros documentos pertinentes – de que adota o uso de percentual aceitável de perdas, quais grupos de insumos foram contemplados com a adoção do indicador e de quanto é o indicador. Nesse sentido, mantém-se a recomendação para a unidade em questão.

Quanto ao item 36, a manifestação da unidade auditada reconhece a importância da recomendação, indicando que esta será atendida.

Quanto ao item 37, como já mencionado anteriormente, reconhece-se que o percentual de 39,50% não reflete a realidade do percentual de perdas da área em questão, tratando-se apenas de uma análise exploratória a respeito do potencial de ganho de eficiência que seria obtido a partir da adoção do percentual de perda como meta de eficiência da gestão de IES.

No item 62 a manifestação do gestor expressa alinhamento com o achado da auditoria e apresenta as providências que serão adotadas. Essas ações serão monitoradas ao longo do acompanhamento das recomendações, garantindo que as medidas corretivas sejam implementadas de forma eficaz e contribuam para a melhoria contínua dos processos.

Quanto ao item 63, foi informado que a demanda está sob a responsabilidade do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria GM/MS nº 5.258, de 16.08.2024, com a finalidade de revisar a Portaria GM/MS nº 4.777, de 30.12.2022, no âmbito do MS e que as sugestões de alterações indicadas no Relatório de Avaliação já foram encaminhadas ao Grupo de Trabalho, e serão devidamente analisadas durante a revisão dos artigos pertinentes. Contudo não foram apresentados novos elementos ao fato que resultassem em alteração ou cancelamento das recomendações.

Em relação aos itens 64 e 65, considerando os riscos envolvidos e a evolução em andamento nos sistemas de informação do MS, como a substituição do sistema Horus pelo Sistema eSUS Assistência Farmacêutica (eSUSAF), que contemplará a interoperação dos dados diários de estoque e saídas para a BNAFAR e dispensações para a RNDS, bem como a reestruturação da BNAFAR, tornando obrigatória a atualização sobre estoques, movimentação de produtos e a dispensação de medicamentos em toda rede pública de saúde (Portaria GM/MS nº 5713, de

09.12.2024), mantém-se a recomendação de incluir no sistema de controle de estoques, as informações de entrada, saída e controle de estoque dos insumos de aquisição centralizada, inclusive os que são entregues diretamente aos entes subnacionais, nos termos do art. 18 § 1º da Portaria GM/MS nº 4777/2022.

Quanto ao item 66, o fluxo de comunicação previsto nos artigos 24 e 25 da Portaria GM/MS nº 4.777/2022 não está sendo cumprido pelas secretarias finalísticas, que não se manifestaram sobre o ponto e a recomendação. A manifestação do gestor concentra-se na atuação do DLOG, que não acrescenta novos elementos. A sugestão de alteração da expressão “estabelecer mecanismos" por "aprimorar mecanismos" no teor da recomendação não pode ser acatada, tendo em vista a necessidade de atuação das secretarias finalísticas. Ademais, com a citada alteração não seria possível mensurar o atendimento da referida recomendação quando de seu processo de monitoramento.

Por fim, com relação ao item 67, o gestor informou sobre o planejamento do processo de gestão de riscos, porém não apresentou elementos que resultassem em alteração ou cancelamento da recomendação.